BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG NHI

Bản cập nhật theo đề cương QĐ3023, trình thẩm định ngày 14/10/2026; chưa ban hành. Gồm 19 quy trình; mã N-01 đến N-19 là đề xuất.

Biên soạn/thẩm định/phê duyệt: …… Số quyết định/ngày hiệu lực: ……

Phạm vi và điều kiện áp dụng

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 dùng cho đề cương và thể thức. Nội dung chuyên môn cần hướng dẫn Nhi tương ứng, nhãn thuốc/IFU và danh mục kỹ thuật được phép của bệnh viện. Người thực hiện phải có phạm vi và năng lực được xác nhận. Tư vấn ngộ độc là hoạt động hỗ trợ được giữ trong bộ nguồn, không đồng nghĩa cho phép điều dưỡng tự quyết định điều trị chống độc.

Trước thuốc và dịch: xác nhận cân nặng kg hiện tại, tuổi, liều mg/kg hoặc đơn vị/kg, trần, tổng mg/đơn vị, nồng độ và ml, tốc độ, tương hợp và tổng dịch. Sơ sinh có hướng dẫn riêng. Kiểm tra độc lập thuốc nguy cơ cao; không coi các danh mục chuẩn bị là y lệnh cho mọi trẻ.

Sửa nội dung nguy cơ trong nguồn về chống co giật, nuôi ăn, xác nhận ống dạ dày, thông tiểu, thoát mạch và PCA. Liều và thông số chưa có dữ liệu thực tế phải được xác nhận trên phiếu cuối bộ trước dùng. Nguồn dẫn chung chưa rõ số hiệu/ấn bản không được coi là đã kiểm chứng.

Danh mục

1. QUY TRÌNH TRUYỀN DỊCH TĨNH MẠCH THƯỜNG QUY
2. QUY TRÌNH TIÊM BẮP
3. QUY TRÌNH KỸ THUẬT TIÊM DƯỚI DA
4. QUY TRÌNH TIÊM TRONG DA
5. QUY TRÌNH TIÊM TĨNH MẠCH, TRUYỀN TĨNH MẠCH
6. QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGHIỆM PHÁP DÂY THẮT
7. QUY TRÌNH KỸ THUẬT LẤY ĐỜM BẰNG TÁC ĐỘNG VỖ RUNG
8. QUY TRÌNH TƯ VẤN NGƯỜI BỆNH NGỘ ĐỘC
9. QUY TRÌNH LẤY DỊCH TỴ HẦU ĐỂ XÉT NGHIỆM
10. QUY TRÌNH ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN
11. QUY TRÌNH CHĂM SÓC CATHETER TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN
12. QUY TRÌNH CHĂM SÓC CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM
13. QUY TRÌNH ĐẶT ỐNG THÔNG DẠ DÀY
14. QUY TRÌNH NUÔI DƯỠNG QUA ỐNG THÔNG DẠ DÀY
15. QUY TRÌNH ĐẶT ỐNG THÔNG DẪN LƯU BÀNG QUANG
16. QUY TRÌNH ĐẶT ỐNG THÔNG TIỂU 1 LẦN
17. QUY TRÌNH KHÍ DUNG THUỐC GIÃN PHẾ QUẢN
18. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH
19. QUY TRÌNH GIẢM ĐAU BẰNG MORPHIN TĨNH MẠCH THEO KIỂU PCA

N-01. QUY TRÌNH TRUYỀN DỊCH TĨNH MẠCH THƯỜNG QUY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Khái niệm: truyền dịch là đưa một lượng thuốc, dịch truyền, các dung dịch cao phân tử hoặc một số dung dịch nuôi dưỡng...vào cơ thể người bệnh qua đường tĩnh mạch.

- Mục đích:

+ Hồi phụ nhanh khối lượng tuần hoàn đã mất.

+ Nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch.

+ Đưa thuốc hoặc hóa chất vào để điều trị

+ Giải độc, lợi tiểu.

- Nguyên tắc chung:

+ Thực hiện theo đúng các bước kỹ thuật.

+ Đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn: rửa tay, kim tiêm, dây truyền chỉ dùng một lần.

+ Thực hiện 5 đúng.

+ Phát hiện tai biến và xử trí đúng khi truyền dịch.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh bị giảm khối lượng tuần hoàn do: sốc, tiêu chảy, bỏng, mất máu cấp...

- Các tình trạng bệnh nặng, chấn thương.

- Người bệnh bị mất máu.

- Người bệnh không ăn được do: hôn mê, tổn thương thực quản, đường tiêu hóa...

- Người bệnh ngộ độc.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Phù phổi cấp.

- Suy tim nặng.

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh mẫn cảm dị ứng với thành phần của dịch truyền.

- Tốc độ liều lượng theo chỉ định của bác sĩ tránh xảy ra tai biến đáng tiếc nhất là đối với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

điều dưỡng 1 người.

Nhân lực đủ năng lực và phạm vi được phân công; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ khi nguy cơ, điều dưỡng không tự mở rộng kỹ thuật.

5.2. Thuốc

- Dịch truyền theo chỉ định của bác sĩ.

- Hộp chống sốc theo quy định.

Thuốc theo y lệnh/nhãn; không có thuốc bắt buộc nếu kỹ thuật không cần. Kiểm tra cân nặng, liều, nồng độ, ml, đường và tốc độ; không tự thay thuốc hoặc pha trộn.

5.3. Vật tư

- Bộ dây truyền, kim truyền cho phù hợp.

- Găng tay (Găng tay sạch), dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

- Dây garo.

- Gạc, Băng keo.

- Hộp đựng bông cồn 700.

Vật tư đúng cỡ trẻ và mục đích, vô khuẩn/dùng một lần khi yêu cầu, vệ sinh tay và hộp vật sắc nhọn; không dùng cỡ người lớn mặc định.

5.4. Trang thiết bị

- Mâm tiêm thuốc.

- Pen, ống cắm pen.

- Máy truyền dịch (nếu cần).

- Trụ treo dịch truyền.

- Máy đo huyết áp, đồng hồ bấm giây, nhiệt kế, ống nghe. bú (bỏ từ này)

- Dụng cụ khác: hộp đựng vật sắc nhọn, thùng đực (đựng) rác thải theo quy định và xe tiêm.

Thiết bị hoạt động tốt, IFU đúng model, bơm/monitor và phương tiện cấp cứu phù hợp trẻ khi cần; kiểm tra trước dùng.

5.5. Người bệnh

Chuẩn bị người bệnh

- Thông báo, giải thích cho người bệnh và gia đình về công việc mình sắp làm.

- Hướng dẫn cho người bệnh đi vệ sinh.

- Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn.

Hai định danh, giải thích phù hợp tuổi, người chăm sóc; nhận định sinh hiệu, nguy cơ và mức hợp tác, không cố giữ trẻ khi không an toàn.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Phiếu chăm sóc.

Chỉ định, cân nặng/tuổi, dị ứng, thuốc đã dùng và kế hoạch theo dõi trong đúng hồ sơ.

5.7. Thời gian thực hiện

theo chỉ định của bác sĩ (dự kiến 5 - 10 phút).

Thời gian theo kỹ thuật/tình trạng, ghi thực tế; không để thời gian ước tính trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

phòng bệnh.

Nơi đủ điều kiện kỹ thuật, hỗ trợ cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn; trẻ cần hồi sức được chuyển nơi phù hợp.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Thực hiện 5 đúng.

- Thực hiện bảng kiểm an toàn kỹ thuật (bỏ).

- Cho người bệnh nằm ngửa thoải mái.

Tạm dừng xác nhận đúng trẻ, chỉ định, vị trí, thuốc/liều/thông số, vật tư và khả năng cấp cứu; xử trí khẩn không chờ hoàn tất hành chính.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: thực hiện 5 đúng (đúng người bệnh, đúng thuốc, đúng liều, đúng đường dùng, đúng thời gian) giải thích cho người bệnh việc sắp làm, hướng dẫn người bệnh đi tiểu trước, cho người bệnh nghỉ ngơi lấy dấu hiệu sinh tồn.

- Bước 2: kiểm tra chất lượng dịch: màu sắc, hạn sử dụng...

- Bước 3: sát khuẩn nắp chai dịch.

- Bước 4: rửa tay thường quy.

- Bước 5: cắm dây truyền vào chai dịch, khóa dây truyền lại, treo chai dịch lên cọc truyền đuổi khí, khóa dây lại và đặt vào khay hạt đậu vô khuẩn.

- Bước 6: vận hành máy truyền dịch (nếu có), chỉnh tốc độ theo chỉ định.

- Bước 7: bộc lộ vùng tiêm truyền. xác định vị trí truyền.

- Bước 8: buộc dây garo.

- Bước 9: sát khuẩn vị trí truyền 2 lần, để khô da.

- Bước 10: điều dưỡng sát khuẩn tay nhanh và đi găng.

Bước 11: đặt catheter phù hợp theo quy trình đặt ngoại biên; không luồn lại kim dẫn đã rút vào catheter. Sử dụng dụng cụ/bơm phù hợp thể tích và cân nặng trẻ.

- Bước 12: tháo dây garo

- Bước 13: nối dây truyền với kim luồn, mở khóa truyền. Kiểm tra máy truyền dịch(nếu có), vận hành chính xác theo chỉ định.

Bước 14: cố định bằng băng phù hợp vô khuẩn, nhìn được vị trí chọc; tránh băng quá chặt. Cài tốc độ ml/giờ, tổng thể tích và giới hạn bơm theo y lệnh, kiểm tra độc lập khi yêu cầu.

- Bước 15: giúp người bệnh ở tư thế thoải mái.

- Bước 16: dặn người bệnh, gia đình những điều cần thiết: khó thở, sắc mặt, tri giác.

- Bước 17: thu dọn dụng cụ, phân loại rác, rửa tay.

- Bước 18: ghi hồ sơ bệnh án và phiếu truyền dịch.

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian/thuốc/liều/thông số thực dùng, vị trí, đáp ứng và sự cố; xử lý dụng cụ/chất thải, hướng dẫn người chăm sóc và bàn giao có người nhận.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi làm thủ thuật

- Quan sát sắc mặt người bệnh.

- Theo dõi tổng trạng.

7.2. Sau khi làm thủ thuật

- Theo dõi tổng trạng.

- Theo dõi dịch truyền, tốc độ.

- Theo dõi vị trí truyền dịch.

7.3. Vỡ mạch

- Nguyên nhân: thành mạch yếu, vị trí truyền bị đâm kim nhiều lần.

Dừng tiêm/truyền khi nghi thoát mạch, không bơm rửa, giữ catheter ban đầu để đánh giá/hút thuốc còn lại theo phác đồ; báo bác sĩ, ghi thuốc, lượng, vùng và tưới máu. Chườm/thuốc giải tùy tác nhân, không tự dùng chung một cách cho mọi thuốc.

7.4. Tắc mạch

- Nguyên nhân: quá trình đuổi khí không tốt vẫn còn khí trong dây truyền.

- Đề phòng: đuổi hết khí trước khi truyền dịch cho người bệnh.

7.5. Sốc

- Nguyên nhân: có thể do dị ứng thành phần dịch, thuốc, truyền dịch quá nhanh…

- Triệu chứng: bồn chồn, hốt hoảng, mẩn ngứa, ban đỏ, nổi mề đay. Mạch nhanh nhỏ, khó bắt khó thở, kích thích, li bì hoặc hôn mê.

- Xử trí: khóa ngay dịch truyền. Xử trí theo phác đồ sốc phản vệ.

7.6. Phù phổi cấp

- Nguyên nhân: truyền nhanh một lượng dịch vào cơ thể. Xảy ra nhiều hơn đối với những người bệnh bị tim mạch.

- Triệu chứng: đau ngực dữ dội (ở trẻ lớn), khó thở, sùi bọt hồng, sắc mặt tím tái, hốt hoảng, kích thích. Nghe phổi thấy có rất nhiều ran ẩm. Mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt.

- Xử trí: ngừng truyền dịch. Cấp cứu hô hấp: mở thông đường thở, thở oxy, đặt nội khí quản, thở máy…Chuẩn bị các phương tiện, thuốc để cấp cứu cùng bác sĩ.

7.7. Nhiễm khuẩn

- Nguyên nhân: do không đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn, lưu kim lâu.

- Hậu quả: nhiễm trùng máu, nhiễm trùng nơi tiêm.

7.8. Phơi nhiễm nhân viên y tế

- Nguyên nhân: kim tiêm vào người bệnh sau đó lại bị đâm vào tay mình trên những người bệnh HIV, viêm gan B,…Do vô khuẩn không tốt.

Phòng ngừa bằng vật sắc nhọn an toàn, không đậy lại nắp kim hai tay. Khi phơi nhiễm: sơ cứu, báo ngay và đánh giá dự phòng theo quy trình; không chỉ quy nguyên nhân do vô khuẩn kém.

Diễn biến nguy hiểm: dừng can thiệp liên quan, đánh giá ABCDE, gọi hỗ trợ và xử trí theo tuổi/phác đồ. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, adrenaline tiêm bắp khi có chỉ định phản vệ theo mức độ, không chờ y lệnh mới tiêm. Theo dõi đủ theo tình trạng, báo cáo sự cố và tái đánh giá trước tiếp tục.

Nguồn đối chiếu

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. File nguồn do bệnh viện cung cấp; hướng dẫn Nhi và nhãn/IFU thực tế phải được xác nhận trước ban hành.

Nguồn tham khảo chuyên môn và an toàn: https://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/Peripheral_Extravasation_Injuries__Initial_management_and_washout_procedure/

Các bảng danh mục trong nguồn không được dùng làm liều hoặc thể tích mặc định. Mục 5 đã tập hợp chuẩn bị; thuốc/cỡ/thông số theo y lệnh và phiếu xác nhận, thay danh mục lặp chưa điều chỉnh theo tuổi.

N-02. QUY TRÌNH TIÊM BẮP

1. ĐẠI CƯƠNG

Tiêm bắp là tiêm một lượng thuốc vào trong bắp thịt (trong cơ), giúp thuốc hấp thu vào cơ thể nhanh hơn tiêm dưới da.

2. CHỈ ĐỊNH

- Cho tất cả các loại thuốc tiêm được vào mô liên kết dưới da đều có thể tiêm bắp thịt được.

- Một số thuốc không nên hay không được tiêm vào tĩnh mạch mà muốn có hiệu quả nhanh hơn dưới da. Thuốc dầu: thuốc chậm tan và gây đau.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Những thuốc gây hoại tử tổ chức: Canxi Clorua, đường ưu trương.

4. THẬN TRỌNG

Người bệnh dị ứng với các thành phần của thuốc.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

điều dưỡng 1 người.

Nhân lực đủ năng lực và phạm vi được phân công; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ khi nguy cơ, điều dưỡng không tự mở rộng kỹ thuật.

5.2. Thuốc

- Theo chỉ định của bác sĩ, hộp chống sốc, nước cất 5ml, dung dịch sát trùng cồn 700.

- Dung dịch sát trùng tay nhanh

Thuốc theo y lệnh/nhãn; không có thuốc bắt buộc nếu kỹ thuật không cần. Kiểm tra cân nặng, liều, nồng độ, ml, đường và tốc độ; không tự thay thuốc hoặc pha trộn.

5.3. Vật tư

- Găng tay, Băng keo.

- Bơm tiêm 5ml, kim rút thuốc 18, bông, gạc miếng, hộp đựng bông cồn.

Vật tư đúng cỡ trẻ và mục đích, vô khuẩn/dùng một lần khi yêu cầu, vệ sinh tay và hộp vật sắc nhọn; không dùng cỡ người lớn mặc định.

5.4. Trang thiết bị

- Mâm tiêm thuốc.

- Pen và trụ cấm pen.

- Hộp đựng vật sắc nhọn, thùng đực rác thải theo qui định.

Thiết bị hoạt động tốt, IFU đúng model, bơm/monitor và phương tiện cấp cứu phù hợp trẻ khi cần; kiểm tra trước dùng.

5.5. Người bệnh

- Nhận định tình trạng người bệnh, hỏi về tiền sử liên quan đến kỹ thuật.

- Giải thích về kỹ thuật sắp làm, gia đình người bệnh cam kết đồng ý kỹ thuật.. Hướng dẫn những điều cần thiết (nếu cần).

Hai định danh, giải thích phù hợp tuổi, người chăm sóc; nhận định sinh hiệu, nguy cơ và mức hợp tác, không cố giữ trẻ khi không an toàn.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Phiếu chăm sóc, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật.

Chỉ định, cân nặng/tuổi, dị ứng, thuốc đã dùng và kế hoạch theo dõi trong đúng hồ sơ.

5.7. Thời gian thực hiện

dự kiến 5 đến 10 phút.

Thời gian theo kỹ thuật/tình trạng, ghi thực tế; không để thời gian ước tính trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

phòng bệnh

Nơi đủ điều kiện kỹ thuật, hỗ trợ cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn; trẻ cần hồi sức được chuyển nơi phù hợp.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra người bệnh. Thực hiện 5 đúng. Người bệnh có thể nằm hoặc ngồi tùy vào vị trí vùng tiêm.

Tạm dừng xác nhận đúng trẻ, chỉ định, vị trí, thuốc/liều/thông số, vật tư và khả năng cấp cứu; xử trí khẩn không chờ hoàn tất hành chính.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: điều dưỡng rửa tay thường quy.

- Bước 2: thực hiện 5 đúng.

- Bước 3: pha và lấy thuốc đúng kỹ thuật.

- Bước 4: kiểm tra thuốc trước khi bỏ vỏ thuốc.

- Bước 5: xác định đúng vị trí tiêm, sát khuẩn vị trí tiêm.

- Bước 6: sát khuẩn tay nhanh mang găng tay (nếu cần thiết).

Bước 7: chọn vị trí/kim/thể tích theo tuổi, khối cơ và thuốc. Ưu tiên vùng cơ đùi trước ngoài ở trẻ nhỏ theo chỉ định; tiêm bắp góc 90°, kiểm tra kỹ thuật theo đúng thuốc/vắc xin, không áp dụng một vị trí/thể tích cho mọi tuổi.

- Bước 8: rút kim, giúp người bệnh trở về tư thế thoải mái và hướng dẫn những điều cần thiết.

- Bước 9: thu dọn dụng cụ phân loại rác, rửa tay, ghi hồ sơ bệnh án.

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian/thuốc/liều/thông số thực dùng, vị trí, đáp ứng và sự cố; xử lý dụng cụ/chất thải, hướng dẫn người chăm sóc và bàn giao có người nhận.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi trong quá trình tiêm

Quan sát sắc mặt, tổng trạng người bệnh, nếu có bất thường (dấu hiệu sốc phản vệ), báo bác sĩ và xử trí theo phác đồ cấp cứu chống shock.

7.2. Theo dõi sau tiêm

Theo dõi sau tiêm theo thuốc/vắc xin, tuổi và nguy cơ, ghi thời điểm; không dùng 15–30 phút làm thời gian chung.

- Phản vệ, dị ứng thuốc: xử trí theo phác đồ cấp cứu chống sốc phản vệ.

- Chảy máu, tụ máu nơi tiêm: cần vệ sinh tại chỗ, dùng bông vô khuẩn khô băng ép lại.

Nghi nhiễm trùng/áp xe hoặc gãy kim: dừng, báo bác sĩ đánh giá; không tự rạch ổ áp xe hoặc đào tìm kim gãy.

- Tắc mạch: do tiêm thuốc dầu vào mạch máu hoặc liệt do tiêm vào dây thần kinh hông to.

Phòng tránh bằng chọn đúng vị trí và kỹ thuật theo tuổi/thuốc. Không hút thử máu khi tiêm vắc xin tại vị trí được khuyến cáo; thuốc khác theo hướng dẫn chế phẩm.

Diễn biến nguy hiểm: dừng can thiệp liên quan, đánh giá ABCDE, gọi hỗ trợ và xử trí theo tuổi/phác đồ. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, adrenaline tiêm bắp khi có chỉ định phản vệ theo mức độ, không chờ y lệnh mới tiêm. Theo dõi đủ theo tình trạng, báo cáo sự cố và tái đánh giá trước tiếp tục.

Nguồn đối chiếu

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. File nguồn do bệnh viện cung cấp; hướng dẫn Nhi và nhãn/IFU thực tế phải được xác nhận trước ban hành.

Nguồn tham khảo chuyên môn và an toàn:
https://www.cdc.gov/injection-safety/hcp/clinical-guidance/

Các bảng danh mục trong nguồn không được dùng làm liều hoặc thể tích mặc định. Mục 5 đã tập hợp chuẩn bị; thuốc/cỡ/thông số theo y lệnh và phiếu xác nhận, thay danh mục lặp chưa điều chỉnh theo tuổi.

N-03. QUY TRÌNH KỸ THUẬT TIÊM DƯỚI DA

1. ĐẠI CƯƠNG

Tiêm dưới da là kỹ thuật đưa thuốc dưới dạng hoà tan trong nước vào tổ chức dưới da cho thuốc hấp thu chậm vào cơ thể.

2. CHỈ ĐỊNH

- Cho tất cả các loại thuốc tiêm được vào dưới da.

Không mặc định atropin phải tiêm dưới da; đường dùng theo đúng chỉ định và chế phẩm.

- Tiêm Atropin trong điều trị giảm đau.

- Tiêm vacxin phòng bệnh: bệnh dại, sởi, quai bị...

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Một số thuốc dầu khó tan, ví dụ: Testosteron...

- Da có vấn đề không thuận lợi để tiêm như nứt nẻ.

4. THẬN TRỌNG

Không nên tiêm vào cùng một vị trí với mỗi lần tiêm, không tiêm vào các khu vực bị bầm tím hay có mô sẹo trên da.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

điều dưỡng 1 người.

Nhân lực đủ năng lực và phạm vi được phân công; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ khi nguy cơ, điều dưỡng không tự mở rộng kỹ thuật.

5.2. Thuốc

- Theo chỉ định của bác sĩ, hộp chống sốc.

- Nước cất 5ml, dung dịch sát trùng: cồn 700

- Dung dịch sát trùng tay nhanh.

Thuốc theo y lệnh/nhãn; không có thuốc bắt buộc nếu kỹ thuật không cần. Kiểm tra cân nặng, liều, nồng độ, ml, đường và tốc độ; không tự thay thuốc hoặc pha trộn.

5.3. Vật tư

- Bơm tiêm 1ml, (bơm 10ml nếu pha thử test), kim rút thuốc số 18, gòn, gạc miếng, hộp đựng bông có cồn.

- Găng tay, băng keo.

Vật tư đúng cỡ trẻ và mục đích, vô khuẩn/dùng một lần khi yêu cầu, vệ sinh tay và hộp vật sắc nhọn; không dùng cỡ người lớn mặc định.

5.4. Trang thiết bị

- Mâm tiêm thuốc.

- Pen, trụ cấm pen.

- Hộp đựng vật sắc nhọn, thùng đực rác thải theo qui định.

Thiết bị hoạt động tốt, IFU đúng model, bơm/monitor và phương tiện cấp cứu phù hợp trẻ khi cần; kiểm tra trước dùng.

5.5. Người bệnh

- Nhận định tình trạng người bệnh, hỏi về tiền sử liên quan đến kỹ thuật.

- Giải thích về kỹ thuật sắp làm: mục đích , các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra, tiên lượng…

- Hướng dẫn những điều cần thiết (nếu cần).

Hai định danh, giải thích phù hợp tuổi, người chăm sóc; nhận định sinh hiệu, nguy cơ và mức hợp tác, không cố giữ trẻ khi không an toàn.

5.6. Hồ sơ bệnh án

phiếu chăm sóc.

Chỉ định, cân nặng/tuổi, dị ứng, thuốc đã dùng và kế hoạch theo dõi trong đúng hồ sơ.

5.7. Thời gian thực hiện

dự kiến 5 - 10 phút.

Thời gian theo kỹ thuật/tình trạng, ghi thực tế; không để thời gian ước tính trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

phòng bệnh.

Nơi đủ điều kiện kỹ thuật, hỗ trợ cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn; trẻ cần hồi sức được chuyển nơi phù hợp.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra người bệnh.

- Thực hiện 5 đúng.

- Thực hiện bảng kiểm an toàn kỹ thuật.

- Cho người bệnh nằm tư thế thoải mái.

Tạm dừng xác nhận đúng trẻ, chỉ định, vị trí, thuốc/liều/thông số, vật tư và khả năng cấp cứu; xử trí khẩn không chờ hoàn tất hành chính.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: điều dưỡng rửa tay thường quy.

- Bước 2: thực hiện 5 đúng.

- Bước 3: pha và lấy thuốc đúng kỹ thuật.

- Bước 4: kiểm tra thuốc trước khi bỏ vỏ ống thuốc.

- Bước 5: xác định đúng vị trí tiêm, sát khuẩn vị trí tiêm.

- Bước 6: sát khuẩn tay nhanh mang găng tay (nếu cần thiết).

Bước 7: véo da khi phù hợp; góc 45° hoặc 90° theo kim, bề dày mô và chế phẩm. Insulin/heparin cần quy trình riêng, vị trí luân phiên và kiểm tra đơn vị, không áp 45° cho mọi trẻ.

- Bước 8: rút kim tiêm an toàn.

Bước 9: ép nhẹ khi cần; không xoa bóp vị trí insulin/heparin hoặc thuốc yêu cầu tránh xoa.

- Bước 10: giúp người bệnh trở về tư thế thoải mái và hướng dẫn những điều cần thiết.

- Bước 11: thu dọn dụng cụ phân loại rác, rửa tay, ghi hồ sơ bệnh án.

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian/thuốc/liều/thông số thực dùng, vị trí, đáp ứng và sự cố; xử lý dụng cụ/chất thải, hướng dẫn người chăm sóc và bàn giao có người nhận.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

- Quan sát sắc mặt, tổng trạng người bệnh, nếu có bất thường (dấu hiệu sốc phản vệ), báo bác sĩ.

Theo dõi sau tiêm theo thuốc/vắc xin, tuổi và nguy cơ, ghi thời điểm; không dùng 15–30 phút làm thời gian chung.

- Sốc phản vệ, dị ứng thuốc: xử trí theo phác đồ cấp cứu chống sốc phản vệ.

- Chảy máu, tụ máu nơi tiêm: cần vệ sinh tại chỗ, dùng bông vô khuẩn khô băng ép lại.

Nghi áp xe: báo bác sĩ khám và chỉ định xử trí, không tự trích rạch.

Gãy kim: dừng, bảo vệ vị trí, báo bác sĩ; không tự đào tìm.

Diễn biến nguy hiểm: dừng can thiệp liên quan, đánh giá ABCDE, gọi hỗ trợ và xử trí theo tuổi/phác đồ. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, adrenaline tiêm bắp khi có chỉ định phản vệ theo mức độ, không chờ y lệnh mới tiêm. Theo dõi đủ theo tình trạng, báo cáo sự cố và tái đánh giá trước tiếp tục.

Nguồn đối chiếu

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. File nguồn do bệnh viện cung cấp; hướng dẫn Nhi và nhãn/IFU thực tế phải được xác nhận trước ban hành.

Nguồn tham khảo chuyên môn và an toàn:
https://www.cdc.gov/injection-safety/hcp/clinical-guidance/

Các bảng danh mục trong nguồn không được dùng làm liều hoặc thể tích mặc định. Mục 5 đã tập hợp chuẩn bị; thuốc/cỡ/thông số theo y lệnh và phiếu xác nhận, thay danh mục lặp chưa điều chỉnh theo tuổi.

N-04. QUY TRÌNH TIÊM TRONG DA

1. ĐẠI CƯƠNG

Tiêm trong da là tiêm một lượng thuốc rất nhỏ (1/10ml) vào lớp thượng bì, chủ yếu để tạo phản ứng da cho tiêm thử phản ứng kháng sinh, tiêm vac xin BCG.

2. CHỈ ĐỊNH

Thử phản ứng/tiêm trong da chỉ khi có chỉ định và phương pháp chuyên môn phù hợp; không thử thường quy mọi kháng sinh.

Kháng sinh/chế phẩm dùng thử phải theo quy trình được bác sĩ xác nhận; kết quả âm không bảo đảm không phản vệ.

+ Huyết thanh: kháng uốn ván, kháng nọc rắn.

- Phòng bệnh: tiêm vacxin BCG phòng lao cho trẻ sơ sinh.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không thử phản ứng khi người bệnh đang có cơn dị ứng cấp tính: viêm mũi, nổi mề đay, hen phế quản.

4. THẬN TRỌNG

Không nên tiêm vào cùng một vị trí với mỗi lần tiêm, không tiêm vào các khu vực bị bầm tím hay có mô sẹo trên da.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

điều dưỡng 1 người

Nhân lực đủ năng lực và phạm vi được phân công; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ khi nguy cơ, điều dưỡng không tự mở rộng kỹ thuật.

5.2. Thuốc

- Theo chỉ định của bác sĩ. Hộp chống sốc, nước cất 5ml (trong trường hợp thử phản ứng), dung dịch sát trùng: cồn700

- Dung dịch sát trùng tay nhanh.

Thuốc theo y lệnh/nhãn; không có thuốc bắt buộc nếu kỹ thuật không cần. Kiểm tra cân nặng, liều, nồng độ, ml, đường và tốc độ; không tự thay thuốc hoặc pha trộn.

5.3. Vật tư

- Bơm tiêm 1ml, (bơm 10ml nếu pha thử test), kim rút thuốc số 18, gòn, gạc miếng, hộp đựng bông có cồn.

- Găng tay, băng keo.

Vật tư đúng cỡ trẻ và mục đích, vô khuẩn/dùng một lần khi yêu cầu, vệ sinh tay và hộp vật sắc nhọn; không dùng cỡ người lớn mặc định.

5.4. Trang thiết bị

- Mâm tiêm thuốc, pen, trụ cấm pen, hộp đựng vật sắc nhọn, thùng đực rác thải theo qui định.

- Bút ghi (trong trường hợp thử phản ứng).

Thiết bị hoạt động tốt, IFU đúng model, bơm/monitor và phương tiện cấp cứu phù hợp trẻ khi cần; kiểm tra trước dùng.

5.5. Người bệnh

- Nhận định tình trạng người bệnh, hỏi về tiền sử liên quan đến kỹ thuật.

- Giải thích về kỹ thuật sắp làm: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra, tiên lượng…

- Hướng dẫn những điều cần thiết (nếu cần).

Hai định danh, giải thích phù hợp tuổi, người chăm sóc; nhận định sinh hiệu, nguy cơ và mức hợp tác, không cố giữ trẻ khi không an toàn.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Phiếu chăm sóc, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật

Chỉ định, cân nặng/tuổi, dị ứng, thuốc đã dùng và kế hoạch theo dõi trong đúng hồ sơ.

5.7. Thời gian thực hiện

dự kiến 15 - 30 phút. (20 - 30 phút)

Thời gian theo kỹ thuật/tình trạng, ghi thực tế; không để thời gian ước tính trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

phòng bệnh.

Nơi đủ điều kiện kỹ thuật, hỗ trợ cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn; trẻ cần hồi sức được chuyển nơi phù hợp.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra người bệnh.

- Thực hiện 5 đúng.

- Thực hiện bảng kiểm an toàn kỹ thuật.

- Cho người bệnh nằm thoải mái.

Tạm dừng xác nhận đúng trẻ, chỉ định, vị trí, thuốc/liều/thông số, vật tư và khả năng cấp cứu; xử trí khẩn không chờ hoàn tất hành chính.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: điều dưỡng rửa tay thường quy.

- Bước 2: thực hiện 5 đúng.

- Bước 3: pha và lấy thuốc đúng kỹ thuật, kiểm tra thuốc trước khi bỏ vỏ thuốc.

- Bước 4: xác định đúng vị trí tiêm, sát khuẩn vị trí tiêm.

- Bước 5: sát khuẩn tay nhanh và mang găng tay.

Bước 6: tiêm trong da đúng vị trí/thể tích theo chế phẩm, mặt vát lên và góc nông theo kỹ thuật; quan sát nốt phồng khi yêu cầu. Không tự pha hoặc dùng tiêm trong da thử phản ứng với mọi thuốc.

- Bước 7: rút kim, giúp người bệnh trở về tư thế thoải mái và hướng dẫn những điều cần thiết.

- Bước 8: thu dọn dụng cụ phân loại rác, rửa tay, ghi hồ sơ bệnh án.

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian/thuốc/liều/thông số thực dùng, vị trí, đáp ứng và sự cố; xử lý dụng cụ/chất thải, hướng dẫn người chăm sóc và bàn giao có người nhận.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi trong quá trình tiêm

Quan sát sắt mặt, tổng trạng người bệnh, nếu có bất thường (dấu hiệu sốc phản vệ) báo bác sĩ.

7.2. Theo dõi sau tiêm

Theo dõi sau tiêm theo thuốc/vắc xin, tuổi và nguy cơ, ghi thời điểm; không dùng 15–30 phút làm thời gian chung.

- Sốc phản vệ, dị ứng thuốc: xử trí theo phác đồ cấp cứu chống sốc phản vệ.

- Chảy máu, tụ máu nơi tiêm: cần vệ sinh tại chỗ, dùng bông vô khuẩn khô băng ép lại.

Nghi nhiễm trùng/áp xe: báo bác sĩ và xử trí theo chỉ định.

Gãy kim: dừng và báo bác sĩ, không tự đào tìm.

Diễn biến nguy hiểm: dừng can thiệp liên quan, đánh giá ABCDE, gọi hỗ trợ và xử trí theo tuổi/phác đồ. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, adrenaline tiêm bắp khi có chỉ định phản vệ theo mức độ, không chờ y lệnh mới tiêm. Theo dõi đủ theo tình trạng, báo cáo sự cố và tái đánh giá trước tiếp tục.

Nguồn đối chiếu

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. File nguồn do bệnh viện cung cấp; hướng dẫn Nhi và nhãn/IFU thực tế phải được xác nhận trước ban hành.

Nguồn tham khảo chuyên môn và an toàn:
https://www.cdc.gov/injection-safety/hcp/clinical-guidance/

Các bảng danh mục trong nguồn không được dùng làm liều hoặc thể tích mặc định. Mục 5 đã tập hợp chuẩn bị; thuốc/cỡ/thông số theo y lệnh và phiếu xác nhận, thay danh mục lặp chưa điều chỉnh theo tuổi.

N-05. QUY TRÌNH TIÊM TĨNH MẠCH, TRUYỀN TĨNH MẠCH

1. ĐẠI CƯƠNG

- Định nghĩa: là cách thức đưa thuốc nhanh vào cơ thể qua đường tĩnh mạch ngoại biên.

- Nguyên tắc chung:

+ Thực hiện theo đúng các bước kỹ thuật.

+ Đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn: rửa tay, bơm kim tiêm dùng một lần...

+ Thực hiện 5 đúng.

+ Phát hiện tai biến và xử lý đúng khi tiêm.

2. CHỈ ĐỊNH

- Cần có tác dụng nhanh của thuốc với cơ thể.

- Cần đưa và cơ thể khối lượng thuốc nhiều.

- Những thuốc gây hoại tử da, tổ chức dưới da, cơ (canxiclorua).

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Những thuốc tan trong dầu (vitamin D3), các loại thuốc có tính chất gây rối loạn nhịp tim, thuốc gây kích thích mạnh với hệ tim mạch, các vùng tĩnh mạch có tình trạng bỏng hoặc nhiễm trùng.

4. THẬN TRỌNG

Các loại thuốc có tính chất gây rối loạn nhịp tim, thuốc tan trong dầu.Thuốc gây kích thích mạnh với hệ tim mạch hay hô hấp tuyệt đối không tiêm vào vùng cơ bị tê liệt, phù nề hay tiêm vào khớp.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

điều dưỡng 1 người.

Nhân lực đủ năng lực và phạm vi được phân công; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ khi nguy cơ, điều dưỡng không tự mở rộng kỹ thuật.

5.2. Thuốc

theo chỉ định của bác sĩ, hộp chống sốc, dung môi, nước cất pha tiêm 5ml, đường glucose 5%, Natriclorid 0,9% (có chỉ định pha tiêm) cồn 700.

Thuốc theo y lệnh/nhãn; không có thuốc bắt buộc nếu kỹ thuật không cần. Kiểm tra cân nặng, liều, nồng độ, ml, đường và tốc độ; không tự thay thuốc hoặc pha trộn.

5.3. Vật tư

- Bơm kim tiêm 5ml, kim bướm, kim luồn các cỡ phù hợp tuổi.

- Gòn, gạc, hộp đựng gòn gạc.

- Găng tay sạch, dây garo.

Vật tư đúng cỡ trẻ và mục đích, vô khuẩn/dùng một lần khi yêu cầu, vệ sinh tay và hộp vật sắc nhọn; không dùng cỡ người lớn mặc định.

5.4. Trang thiết bị

- Mâm tiêm thuốc.

- Pen, ống cắm pen.

- Thùng đực rác thải theo quy định.

- Hộp đựng vật sắc nhọn.

Thiết bị hoạt động tốt, IFU đúng model, bơm/monitor và phương tiện cấp cứu phù hợp trẻ khi cần; kiểm tra trước dùng.

5.5. Người bệnh

- Giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh.

- Giải thích về kỹ thuật sắp làm: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra, tiên lượng…

- Hướng dẫn những điều cần thiết (nếu cần).

Hai định danh, giải thích phù hợp tuổi, người chăm sóc; nhận định sinh hiệu, nguy cơ và mức hợp tác, không cố giữ trẻ khi không an toàn.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Phiếu chăm sóc.

Chỉ định, cân nặng/tuổi, dị ứng, thuốc đã dùng và kế hoạch theo dõi trong đúng hồ sơ.

5.7. Thời gian thực hiện

dự kiến 5 - 10 phút.

Thời gian theo kỹ thuật/tình trạng, ghi thực tế; không để thời gian ước tính trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

phòng bệnh.

Nơi đủ điều kiện kỹ thuật, hỗ trợ cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn; trẻ cần hồi sức được chuyển nơi phù hợp.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra người bệnh.

- Thực hiện 5 đúng.

- Thực hiện bảng kiểm an toàn kỹ thuật.

- Cho người bệnh nằm ngửa thoải mái.

Tạm dừng xác nhận đúng trẻ, chỉ định, vị trí, thuốc/liều/thông số, vật tư và khả năng cấp cứu; xử trí khẩn không chờ hoàn tất hành chính.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: thực hiện 5 bước (đúng người bệnh, đúng thuốc, đúng liều dùng, đúng đường dùng, đúng thời gian).

- Bước 2: rửa tay thường quy hoặc sát khuẩn tay nhanh.

- Bước 3: sát khuẩn nắp lọ thuốc, dung môi.

Pha thuốc bằng dung môi, nồng độ và thao tác theo nhãn/tài liệu tương hợp; không mặc định lắc mạnh mọi thuốc. Ghi nhãn, thời hạn sau pha và kiểm tra liều mg/kg, mg, ml.

- Bước 5: rút thuốc đúng chỉ định, đuổi khí.

- Bước 6: tìm vị trí tiêm thích hợp, hướng dẫn người nhà cách bế trẻ (nếu là trẻ nhỏ).

- Bước 7: buộc dây garo.

- Bước 8: sát khuẩn nơi tiêm bông thấm cồn 70%, để da khô.

- Bước 9: luồn kim vào trong lòng tĩnh mạch. Một tay đỡ dưới vị trí tiêm (tay hoặc chân) căng da vùng tiêm, tay còn lại cầm kim mũi vát ngửa lên trên, đâm kim với góc chếch khoảng 15 - 30°. Khi thấy có máu trào ra vùng đốc kim thì hạ thấp kim tiêm luồn vào tĩnh mạch rồi dừng lại.

- Bước 10: tháo dây garo bơm thuốc thật từ từ theo chỉ định bác sĩ. Quan sát thật kỹ người bệnh trong quá trình tiêm.

- Bước 11: rút kim nhanh, căng da và đặt bông gòn vào nơi tiêm khi hết thuốc.

- Thực hành kỹ thuật tiêm tĩnh mạch khi người bệnh đang truyền dịch cần chú ý:

+ Không cần buộc dây garo nhưng phải chú ý khóa lại dịch truyền.

Dùng cổng kết nối phù hợp, sát khuẩn và chờ khô theo quy trình; không chọc kim vào cổng không được thiết kế cho kim.

Bơm theo tốc độ chỉ định, kiểm tra tương hợp và bơm rửa thể tích cá thể theo đường truyền; không dùng thể tích cố định người lớn.

+ Mở khoá cho dịch chảy theo y định của bác sĩ.

- Bước 12: giúp người bệnh trở về tư thế thoải mái.

- Bước 13: dặn người bệnh, gia đình người bệnh những điều cần thiết (khó thở, sắc mặt, tri giác).

- Bước 14: thu dọn dụng cụ phân loại rác, rửa tay và ghi hồ sơ bệnh án.

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian/thuốc/liều/thông số thực dùng, vị trí, đáp ứng và sự cố; xử lý dụng cụ/chất thải, hướng dẫn người chăm sóc và bàn giao có người nhận.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

- Theo dõi trong quá trình tiêm: quan sát sắc mặt người bệnh, nếu có dấu hiệu sốc phản vệ, dừng tiêm, báo bác sĩ xử trí theo phác đồ. Trong quá trình tiêm có thể xảy ra tắc kim tiêm, phồng nơi tiêm, người bệnh hoảng sợ ...

- Theo dõi sau tiêm: phản ứng dị ứng muộn: nổi mẩn tại chỗ tiêm hoặc toàn thân.

Tắc đường truyền: dừng, kiểm tra gập/kẹp và đánh giá; không cố bơm đẩy cục máu hoặc dùng lại kim có máu đông.

Dừng tiêm/truyền khi nghi thoát mạch, không bơm rửa, giữ catheter ban đầu để đánh giá/hút thuốc còn lại theo phác đồ; báo bác sĩ, ghi thuốc, lượng, vùng và tưới máu. Chườm/thuốc giải tùy tác nhân, không tự dùng chung một cách cho mọi thuốc.

- Người bị bệnh ngất, hoảng sợ: cần làm tốt công tác tâm lý cho người bệnh trước khi tiêm thuốc.

- Tắc mạch: nguyên nhân do không khí ở trong bơm tiêm vào lòng mạch, tiêm nhầm thuốc tan trong dầu, dạng sữa. Đề phòng đuổi hết không khí trong bơm tiêm trước khi tiêm thuốc cho người bệnh. Chú ý 5 đúng tránh nhầm thuốc.

- Nhiễm khuẩn: nguyên nhân do vô khuẩn không tốt, lưu kim kéo dài. Đề phòng: Thực hiện tốt công tác vô khuẩn trước, trong và sau khi tiêm thuốc cho người bệnh. Ghi nhớ thời gian lưu kim.

- Sốc phản vệ: nguyên nhân do phản ứng của cơ thể với thuốc. Biểu hiện: bồn chồn, hốt hoảng, sợ hãi, kích thích li bì hoặc hôn mê, mạch nhanh nhỏ, khó bắt, khó thở, tím tái. Nhẹ hơn là mẩn ngứa, ban đỏ, mày đay dị ứng. Xử trí: ngừng tiêm, xử trí theo phác đồ cấp cứu sốc phản vệ.

Diễn biến nguy hiểm: dừng can thiệp liên quan, đánh giá ABCDE, gọi hỗ trợ và xử trí theo tuổi/phác đồ. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, adrenaline tiêm bắp khi có chỉ định phản vệ theo mức độ, không chờ y lệnh mới tiêm. Theo dõi đủ theo tình trạng, báo cáo sự cố và tái đánh giá trước tiếp tục.

Nguồn đối chiếu

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. File nguồn do bệnh viện cung cấp; hướng dẫn Nhi và nhãn/IFU thực tế phải được xác nhận trước ban hành.

Nguồn tham khảo chuyên môn và an toàn: https://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/peripheral_extravasation_injuries/

Các bảng danh mục trong nguồn không được dùng làm liều hoặc thể tích mặc định. Mục 5 đã tập hợp chuẩn bị; thuốc/cỡ/thông số theo y lệnh và phiếu xác nhận, thay danh mục lặp chưa điều chỉnh theo tuổi.

N-06. QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGHIỆM PHÁP DÂY THẮT

1. ĐẠI CƯƠNG

Nghiệm pháp dây thắt (Tourniquet test) là một phương pháp chẩn đoán đơn giản nhằm đánh giá tình trạng tăng tính thấm thành mạch, thường được áp dụng trong các trường hợp nghi ngờ bệnh sốt xuất huyết Dengue. Nguyên lý dựa trên việc làm tăng áp lực mao mạch bằng cách thắt tĩnh mạch cánh tay, từ đó quan sát sự xuất hiện các chấm xuất huyết dưới da.

Mục đích: giúp sàng lọc và hỗ trợ chẩn đoán các bệnh lý gây xuất huyết dưới da, đặc biệt là sốt xuất huyết Dengue.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh nghi ngờ mắc sốt xuất huyết Dengue (theo tiêu chuẩn lâm sàng). Cần đánh giá mức độ xuất huyết dưới da trong một số bệnh lý huyết học.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh đang có xuất huyết tự nhiên hoặc đã có dấu hiệu xuất huyết dưới da rõ ràng. Người bệnh đang trong tình trạng sốc. Người bệnh có bệnh lý da tại vị trí thực hiện (viêm da, nhiễm trùng,…).

- Có chống chỉ định làm tăng áp lực vùng chi trên (như huyết khối tĩnh mạch sâu, tổn thương cánh tay).

4. THẬN TRỌNG

Đánh giá chỉ định, tuổi và khả năng chịu đựng theo hướng dẫn chẩn đoán Dengue; không tự áp một giới hạn tuổi không có căn cứ. Không thực hiện khi sốc/xuất huyết đã rõ và không để nghiệm pháp trì hoãn hồi sức.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp: điều dưỡng có chuyên môn, được đào tạo về kỹ thuật.

b) Nhân lực hỗ trợ: Không bắt buộc (nếu người bệnh hợp tác tốt).

Nhân lực đủ năng lực và phạm vi được phân công; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ khi nguy cơ, điều dưỡng không tự mở rộng kỹ thuật.

5.2. Thuốc

Không sử dụng thuốc trong kỹ thuật này.

Thuốc theo y lệnh/nhãn; không có thuốc bắt buộc nếu kỹ thuật không cần. Kiểm tra cân nặng, liều, nồng độ, ml, đường và tốc độ; không tự thay thuốc hoặc pha trộn.

5.3. Vật tư

Băng quấn huyết áp đúng cỡ, bút, đồng hồ và khuôn đo diện tích; không thay bằng garo cao su không kiểm soát được áp lực.

Vật tư đúng cỡ trẻ và mục đích, vô khuẩn/dùng một lần khi yêu cầu, vệ sinh tay và hộp vật sắc nhọn; không dùng cỡ người lớn mặc định.

5.4. Trang thiết bị

Giường bệnh hoặc ghế tựa. Đèn chiếu sáng (nếu cần).

Thiết bị hoạt động tốt, IFU đúng model, bơm/monitor và phương tiện cấp cứu phù hợp trẻ khi cần; kiểm tra trước dùng.

5.5. Người bệnh

Được giải thích quy trình, đồng ý hợp tác. Ở tư thế ngồi hoặc nằm thoải mái.

Hai định danh, giải thích phù hợp tuổi, người chăm sóc; nhận định sinh hiệu, nguy cơ và mức hợp tác, không cố giữ trẻ khi không an toàn.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án có ghi nhận chỉ định thực hiện nghiệm pháp dây thắt.

Chỉ định, cân nặng/tuổi, dị ứng, thuốc đã dùng và kế hoạch theo dõi trong đúng hồ sơ.

5.7. Thời gian thực hiện

Ước tính: 20 phút (bao gồm chuẩn bị, thực hiện và ghi nhận kết quả).

Thời gian theo kỹ thuật/tình trạng, ghi thực tế; không để thời gian ước tính trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng khám, phòng cấp cứu, buồng bệnh.

Nơi đủ điều kiện kỹ thuật, hỗ trợ cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn; trẻ cần hồi sức được chuyển nơi phù hợp.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đảm bảo có chỉ định của bác sĩ, không có chống chỉ định.

Tạm dừng xác nhận đúng trẻ, chỉ định, vị trí, thuốc/liều/thông số, vật tư và khả năng cấp cứu; xử trí khẩn không chờ hoàn tất hành chính.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Các bước thực hiện

- Bước 1: giải thích kỹ thuật cho người bệnh và cho họ nằm hoặc ngồi thoải mái.

- Bước 2: đeo găng tay, xác định vị trí mặt trước cẳng tay không bị tổn thương.

- Bước 3: quấn bao đo huyết áp quanh cánh tay người bệnh và bơm lên mức trung bình giữa huyết áp tối đa và tối thiểu.

- Bước 4: giữ nguyên áp lực trong 5 phút.

- Bước 5: tháo bao, đợi khoảng 2 phút

- Bước 6: đếm số chấm xuất huyết trên diện tích 2,5 cm x 2,5 cm, ghi nhận kết quả.

- Bước 7: đánh giá kết quả:

Ghi số chấm và diện tích đo; bác sĩ diễn giải theo hướng dẫn Dengue đang áp dụng và nhóm tuổi.

Âm tính không loại trừ Dengue, dương tính không tự xác định chẩn đoán; không dùng một ngưỡng chưa đối chiếu làm căn cứ độc lập.

- Bước 8: kết thúc quy trình.

6.3. Ghi hồ sơ

Ghi nhận ngày giờ thực hiện, kết quả, tên người thực hiện vào hồ sơ bệnh án.

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian/thuốc/liều/thông số thực dùng, vị trí, đáp ứng và sự cố; xử lý dụng cụ/chất thải, hướng dẫn người chăm sóc và bàn giao có người nhận.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

- Đau, khó chịu do thắt bao quá chặt.

- Bầm tím hoặc xuất huyết lan rộng nếu có rối loạn đông máu.

7.2. Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

- Phù cánh tay tạm thời.

- Đau nhức nhẹ vùng thắt dây.

7.3. Biến chứng muộn

Hiếm gặp: có thể xuất hiện bầm tím kéo dài nếu người bệnh có bệnh lý nền đông máu.

Diễn biến nguy hiểm: dừng can thiệp liên quan, đánh giá ABCDE, gọi hỗ trợ và xử trí theo tuổi/phác đồ. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, adrenaline tiêm bắp khi có chỉ định phản vệ theo mức độ, không chờ y lệnh mới tiêm. Theo dõi đủ theo tình trạng, báo cáo sự cố và tái đánh giá trước tiếp tục.

Nguồn đối chiếu

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. File nguồn do bệnh viện cung cấp; hướng dẫn Nhi và nhãn/IFU thực tế phải được xác nhận trước ban hành.

Các bảng danh mục trong nguồn không được dùng làm liều hoặc thể tích mặc định. Mục 5 đã tập hợp chuẩn bị; thuốc/cỡ/thông số theo y lệnh và phiếu xác nhận, thay danh mục lặp chưa điều chỉnh theo tuổi.

N-07. QUY TRÌNH KỸ THUẬT LẤY ĐỜM BẰNG TÁC ĐỘNG VỖ RUNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Lấy đờm bằng tác động vỗ rung là kỹ thuật hỗ trợ dẫn lưu và tống xuất đờm từ phổi ra ngoài bằng các biện pháp cơ học như vỗ lồng ngực kết hợp rung để làm long đờm. Kỹ thuật này giúp cải thiện thông khí, giảm nguy cơ tắc nghẽn đường thở, hỗ trợ điều trị các bệnh lý đường hô hấp có tăng tiết đờm như viêm phổi, COPD, giãn phế quản.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh đặt ống nộ khí quản, mở khí quản..

- Các bệnh về phổi: viêm phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), áp xe phổi, hen phế quản...

- Người bệnh nằm lâu ngày ít cử động: người bệnh hôn mê, liệt.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương sườn, loãng xương nặng.

- Chấn thương lồng ngực, phổi.

- Có khối u, tổn thương da tại vùng ngực cần vỗ.

- Sau phẫu thuật lồng ngực chưa ổn định.

- Tăng áp lực nội sọ, chảy máu phổi, tràn khí màng phổi chưa dẫn lưu.

4. THẬN TRỌNG

- Cần xác định đúng vị trí vỗ để đạt hiệu quả dẫn lưu.

- Không vỗ sau khi người bệnh ăn no (nên thực hiện trước bữa ăn 1 giờ hoặc sau ăn ít nhất 2 giờ).

- Theo dõi người bệnh trong quá trình thực hiện để ngưng kỹ thuật nếu có dấu hiệu bất thường như khó thở, tím tái.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

01 điều dưỡng đã được đào tạo kỹ thuật vỗ rung lấy đờm.

Nhân lực đủ năng lực và phạm vi được phân công; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ khi nguy cơ, điều dưỡng không tự mở rộng kỹ thuật.

5.2. Thuốc

Natriclorua 0,9%.

Thuốc theo y lệnh/nhãn; không có thuốc bắt buộc nếu kỹ thuật không cần. Kiểm tra cân nặng, liều, nồng độ, ml, đường và tốc độ; không tự thay thuốc hoặc pha trộn.

5.3. Vật tư

- Khẩu trang y tế, găng tay sạch.

- Khăn giấy sạch hoặc khăn vải.

Vật tư đúng cỡ trẻ và mục đích, vô khuẩn/dùng một lần khi yêu cầu, vệ sinh tay và hộp vật sắc nhọn; không dùng cỡ người lớn mặc định.

5.4. Trang thiết bị

Khay hạt đậu hoặc bô/chậu đựng đờm, túi rác y tế.

Thiết bị hoạt động tốt, IFU đúng model, bơm/monitor và phương tiện cấp cứu phù hợp trẻ khi cần; kiểm tra trước dùng.

5.5. Người bệnh

Được giải thích về thủ thuật, hợp tác tốt.

Mặc quần áo rộng rãi, thoải mái.

Nghỉ ngơi yên tĩnh ít nhất 15 - 30 phút trước thực hiện.

Hai định danh, giải thích phù hợp tuổi, người chăm sóc; nhận định sinh hiệu, nguy cơ và mức hợp tác, không cố giữ trẻ khi không an toàn.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án hoặc bảng theo dõi điều dưỡng có chỗ ghi nhận kết quả thực hiện kỹ thuật.

Chỉ định, cân nặng/tuổi, dị ứng, thuốc đã dùng và kế hoạch theo dõi trong đúng hồ sơ.

5.7. Thời gian thực hiện

Ước tính: 0.5 giờ (bao gồm chuẩn bị, thực hiện và ghi nhận kết quả).

Thời gian theo kỹ thuật/tình trạng, ghi thực tế; không để thời gian ước tính trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng khám, phòng cấp cứu, buồng bệnh.

Nơi đủ điều kiện kỹ thuật, hỗ trợ cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn; trẻ cần hồi sức được chuyển nơi phù hợp.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đảm bảo có chỉ định của bác sĩ, không có chống chỉ định.

Tạm dừng xác nhận đúng trẻ, chỉ định, vị trí, thuốc/liều/thông số, vật tư và khả năng cấp cứu; xử trí khẩn không chờ hoàn tất hành chính.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: giải thích thủ thuật cho người bệnh để tạo sự hợp tác.

- Bước 2: cho người bệnh nằm hoặc ngồi ở tư thế phù hợp tùy vùng phổi cần dẫn lưu.

- Bước 3: điều dưỡng rửa tay, mang găng sạch và khẩu trang.

- Bước 4: xác định vùng phổi cần dẫn lưu, vỗ đúng vùng, tránh vùng xương ức, xương sống, xương bả vai, thận.

- Bước 5: dùng bàn tay chụm lại thành hình chén, vỗ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đều tay lên vùng cần vỗ trong 3 - 5 phút.

- Bước 6: kết hợp rung ngực (nếu có thể): khi người bệnh hít vào sâu, điều dưỡng ép nhẹ bàn tay lên thành ngực theo nhịp thở ra để hỗ trợ đẩy đờm ra ngoài.

- Bước 7: khuyến khích người bệnh ho mạnh để tống đờm ra ngoài.

- Bước 8: hỗ trợ người bệnh khạc đờm vào khăn giấy, khay hoặc dụng cụ đựng đờm.

- Bước 9: lau sạch vùng da vỗ rung nếu có mồ hôi hoặc chất tiết.

- Bước 10: thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian/thuốc/liều/thông số thực dùng, vị trí, đáp ứng và sự cố; xử lý dụng cụ/chất thải, hướng dẫn người chăm sóc và bàn giao có người nhận.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi: sát mạch, SPO2, nhịp thở của người bệnh trước, trong và sau khi tiến hành vỗ rung.

7.2. Xử trí tai biến

- Suy hô hấp: SPO2 tụt, sắc mặt tím tái,thở nhanh hoặc chậm... Ngừng vỗ rung, cho người bệnh về tư thế thích hợp, tăng oxy và hút đờm (nếu cần).

- Chấn thương lồng ngực do kỹ thuật thô bạo: Khi vỗ phải đảm bảo đúng kỹ thuật.

- Một số chú ý khi vỗ, rung:

+ Tổng thời gian vỗ và rung không quá 30 - 40 phút. Khi tiến hành phải luôn theo dõi sát mạch, nhịp thở, SPO2, sắc mặt người bệnh.

+ Khi vỗ rung nhắc người bệnh nhịn ho (nếu người bệnh tỉnh) đến khi mắc ho nhiều thì gắng sức ho khạc cho đờm, mủ tống ra được nhiều. Vỗ rung xong nên hút đờm ngay bên vừa vỗ rung rồi mới sang bên kia.

Diễn biến nguy hiểm: dừng can thiệp liên quan, đánh giá ABCDE, gọi hỗ trợ và xử trí theo tuổi/phác đồ. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, adrenaline tiêm bắp khi có chỉ định phản vệ theo mức độ, không chờ y lệnh mới tiêm. Theo dõi đủ theo tình trạng, báo cáo sự cố và tái đánh giá trước tiếp tục.

Nguồn đối chiếu

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. File nguồn do bệnh viện cung cấp; hướng dẫn Nhi và nhãn/IFU thực tế phải được xác nhận trước ban hành.

Các bảng danh mục trong nguồn không được dùng làm liều hoặc thể tích mặc định. Mục 5 đã tập hợp chuẩn bị; thuốc/cỡ/thông số theo y lệnh và phiếu xác nhận, thay danh mục lặp chưa điều chỉnh theo tuổi.

N-08. QUY TRÌNH TƯ VẤN NGƯỜI BỆNH NGỘ ĐỘC

1. ĐẠI CƯƠNG

- Tư vấn là phần rất quan trọng trong khi chẩn đoán và điều trị người bệnh nói chung và đặc biệt là trong ngộ độc. Người thực hiện tốt nhất của người bệnh chính là bản thân họ. Nhiệm vụ của người bác sĩ là giải thích để người bệnh hiểu điều đó và phối hợp trong điều trị bệnh.

- Đối với người bệnh ngộ độc, tùy theo nguyên nhân ngộ độc để có cách tư vấn hợp lý. Người bệnh tự tử thường có vấn đề về tâm thần, cần khai thác và hội chẩn thêm chuyên khoa Tâm thần.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh ngộ độc (tỉnh táo, nói chuyện tiếp xúc được).

- Một số thành viên trong gia đình người bệnh.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định.

4. THẬN TRỌNG

Tư vấn sau ổn định cấp cứu, phù hợp tuổi, bảo mật và khả năng giao tiếp. Khi có nguy cơ tự hại hoặc bạo hành, cần đánh giá chuyên khoa và kế hoạch bảo vệ, không chỉ động viên rồi cho về.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

1 Bác sĩ, 1 điều dưỡng: quần áo, đội mũ,đeo khẩu trang (trong một số trường hợp người bệnh có nguy cơ bệnh lây nhiễm).

Nhân lực đủ năng lực và phạm vi được phân công; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ khi nguy cơ, điều dưỡng không tự mở rộng kỹ thuật.

5.2. Thuốc

dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Thuốc theo y lệnh/nhãn; không có thuốc bắt buộc nếu kỹ thuật không cần. Kiểm tra cân nặng, liều, nồng độ, ml, đường và tốc độ; không tự thay thuốc hoặc pha trộn.

5.3. Vật tư

- Khẩu trang phẫu thuật: 2 cái.

- Mũ phẫu thuật: 2 cái.

- Găng tay: 2 đôi.

Vật tư đúng cỡ trẻ và mục đích, vô khuẩn/dùng một lần khi yêu cầu, vệ sinh tay và hộp vật sắc nhọn; không dùng cỡ người lớn mặc định.

5.4. Trang thiết bị

- Giường bệnh, cáng nếu người bệnh đang nằm viện.

- Phòng tư vấn riêng (nếu người bệnh tới khám tư vấn): không gian yên tĩnh, có điều hòa nhiệt độ hoặc mát mẻ về mùa Hè, ấm về mùa Đông.

- Bàn ghế cho bác sĩ, ghế cho người bệnh và người nhà người bệnh, có một số tờ rơi, poster, có thể có băng đĩa hình, đầu quay video về phòng tránh ngộ độc chung và một số ngộ độc thông thường, một số thông tin về bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe định kỳ.

- Chi phí khác: tiêu hao điện, nước, xử trí rác thải, vệ sinh buồng bệnh môi trường, chăn ga, khấu hao điều hòa - nhà cửa.

Thiết bị hoạt động tốt, IFU đúng model, bơm/monitor và phương tiện cấp cứu phù hợp trẻ khi cần; kiểm tra trước dùng.

5.5. Người bệnh

Người bệnh đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt nằm trên giường bệnh hoặc ngồi ghế để nghe và nói chuyện cùng người thực hiện.

Hai định danh, giải thích phù hợp tuổi, người chăm sóc; nhận định sinh hiệu, nguy cơ và mức hợp tác, không cố giữ trẻ khi không an toàn.

5.6. Hồ sơ bệnh án

ghi rõ chẩn đoán, nguyên nhân ngộ độc và đánh giá tổn thương.

Chỉ định, cân nặng/tuổi, dị ứng, thuốc đã dùng và kế hoạch theo dõi trong đúng hồ sơ.

5.7. Thời gian thực hiện

Ước tính: 0.5 giờ (bao gồm chuẩn bị, thực hiện và ghi nhận kết quả).

Thời gian theo kỹ thuật/tình trạng, ghi thực tế; không để thời gian ước tính trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng khám, phòng cấp cứu, buồng bệnh.

Nơi đủ điều kiện kỹ thuật, hỗ trợ cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn; trẻ cần hồi sức được chuyển nơi phù hợp.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đảm bảo có chỉ định của bác sĩ, không có chống chỉ định.

Tạm dừng xác nhận đúng trẻ, chỉ định, vị trí, thuốc/liều/thông số, vật tư và khả năng cấp cứu; xử trí khẩn không chờ hoàn tất hành chính.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Đề nghị người bệnh hoặc người nhà nêu vấn đề cần hỏi. Bác sĩ trả lời, giải thích các câu hỏi của người bệnh. Mở rộng các vấn đề liên quan tới câu hỏi của người bệnh để hướng dẫn phòng tránh và điều trị hợp lý. Cuối buổi tư vấn cần có câu tóm tắt, kết luận về vấn đề tư vấn. Tùy theo nguyên nhân ngộ độc để có các tư vấn hợp lý.

Ví dụ:

- Nguyên nhân ngộ độc do ăn uống nhầm phải chất độc (thường gặp ở trẻ em, người già bị lẫn lộn, người bệnh tâm thần, say rượu): cần giải thích cho người bệnh và người nhà:

+ Không để các hóa chất trong gia đình (chất tẩy rửa, vệ sinh, khử mùi, xăng dầu…), các hóa chất bảo vệ thực vật (hóa chất trừ sâu, trừ cỏ, hóa chất kích thích tăng trưởng…) vào các chai lọ đựng đồ ăn, uống (chai đựng nước ngọt, nước lọc). + Có nơi quản lý riêng với các hóa chất, đặc biệt là các hóa chất bảo vệ thực vật cần có thùng hoặc kho đựng riêng, có khóa. Chỉ những người được đào tạo, được hướng dẫn đầy đủ mới được sử dụng các hóa chất đó.

+ Để xa tầm với của trẻ em tất cả các thuốc, hóa chất, cặp nhiệt độ…

+ Không đánh bả chuột ở những nơi trẻ em hay chơi đùa hoặc dễ nhìn thấy.

+ Bảo quản và chế biến thực phẩm đúng cách

- Ngộ độc do ăn phải chất độc có sẵn trong thức ăn:

+ Không ăn nấm tự hái ở rừng vì không thể phân biệt được giữa nấm lành và nấm độc. Không ăn hoa quả không rõ loại

+ Thu hái rau quả sau khi phun hóa chất bảo vệ thực vật đủ thời gian an toàn.

+ Không sử dụng phẩm màu công nghiệp trong chế biến thực phẩm.

- Ngộ độc do nguyên nhân tự tử: đây là nhóm người bệnh cần được tư vấn kỹ nhất và khó nhất. Tìm hiểu nguyên nhân thực sự làm người bệnh tự tử mới có thể tháo gỡ được: buồn vì bệnh tật, bị bạo hành, cưỡng bức, vì thua cờ bạc, nợ nần, mâu thuẫn trong gia đình hoặc bạn bè, đồng nghiệp, nghiện ngập…

Lắng nghe không phán xét, đánh giá nguy cơ tự hại hiện tại theo chuyên khoa; bảo đảm giám sát an toàn khi nguy cơ cao, hạn chế tiếp cận phương tiện gây hại, hội chẩn và lập kế hoạch theo dõi. Giải thích bảo mật và giới hạn khi cần bảo vệ trẻ/người bệnh; không cam kết tư vấn sẽ ngăn tái diễn.

- Ngộ độc vì lạm dụng ma túy, rượu…đây là vấn đề không dễ giải quyết. Giải thích và phối hợp cùng gia đình, tư vấn và gợi ý một số địa chỉ các Trung tâm cai nghiện giúp người bệnh và gia đình.

- Ngộ độc do bị đầu độc: khám và đánh giá các triệu chứng khách quan, xét nghiệm độc chất, tư vấn cho gia đình và người bệnh cùng phối hợp điều trị, thông báo cho cơ quan thực thi Pháp luật.

- Sau khi tư vấn, cần hỏi lại người bệnh và người nhà người bệnh trước khi kết thúc xem người bệnh đã đồng ý với các câu trả lời chưa, đã hiểu rõ vấn đề chưa, cần thêm thông tin về ngộ độc không.

- Trong khi tư vấn cần tăng cường giáo dục về phòng tránh ngộ độc.

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian/thuốc/liều/thông số thực dùng, vị trí, đáp ứng và sự cố; xử lý dụng cụ/chất thải, hướng dẫn người chăm sóc và bàn giao có người nhận.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

- Theo dõi các diễn biến tâm lý của người bệnh để điều chỉnh tư vấn cho hợp lý.

- Cần tư vấn nhiều lần.

- Tránh giải thích quá sâu chuyên môn dẫn đến lo lắng (ví dụ ít nguy cơ lại giải thích nhiều về các biến chứng nặng nề, ung thư hóa…)

- Nếu kết thúc tư vấn người bệnh vẫn chưa hết thắc mắc thì cần mời hội chẩn tư vấn tiếp.

Diễn biến nguy hiểm: dừng can thiệp liên quan, đánh giá ABCDE, gọi hỗ trợ và xử trí theo tuổi/phác đồ. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, adrenaline tiêm bắp khi có chỉ định phản vệ theo mức độ, không chờ y lệnh mới tiêm. Theo dõi đủ theo tình trạng, báo cáo sự cố và tái đánh giá trước tiếp tục.

Nguồn đối chiếu

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. File nguồn do bệnh viện cung cấp; hướng dẫn Nhi và nhãn/IFU thực tế phải được xác nhận trước ban hành.

Các bảng danh mục trong nguồn không được dùng làm liều hoặc thể tích mặc định. Mục 5 đã tập hợp chuẩn bị; thuốc/cỡ/thông số theo y lệnh và phiếu xác nhận, thay danh mục lặp chưa điều chỉnh theo tuổi.

N-09. QUY TRÌNH LẤY DỊCH TỴ HẦU ĐỂ XÉT NGHIỆM

1. ĐẠI CƯƠNG

- Lấy dịch tỵ hầu là kỹ thuật đưa que lấy mẫu qua đường mũi đến vùng tỵ hầu để thu thập dịch tiết. Mẫu thu được dùng trong xét nghiệm phát hiện các vi sinh vật gây bệnh, đặc biệt là SARS-CoV-2, cúm, RSV…

- Nguyên lý: dựa vào nguyên tắc thu mẫu đúng vị trí giải phẫu, đảm bảo vô khuẩn để tránh sai lệch kết quả.

Mục đích: giúp chẩn đoán bệnh lý đường hô hấp trên.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người nghi nhiễm bệnh hô hấp do vi khuẩn, virus.

- Người có tiếp xúc gần với ca bệnh.

- Người bệnh cần sàng lọc trước phẫu thuật, thủ thuật.

- Người bệnh có triệu chứng sốt, ho, đau họng, mất khứu giác, khó thở…

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người có vách ngăn mũi bị lệch nhiều.

- Người đang chảy máu cam.

- Người bệnh có tổn thương vùng mũi hoặc phẫu thuật mũi gần đây.

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh rối loạn đông máu.

- Người bệnh không hợp tác, dễ kích thích hắt hơi, nôn ói.

- Cần mang đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân để tránh lây nhiễm chéo.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) 01 Điều dưỡng hoặc kỹ thuật viên được đào tạo.

b) Nhân lực hỗ trợ: điều dưỡng phụ nếu cần cố định người bệnh.

Nhân lực đủ năng lực và phạm vi được phân công; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ khi nguy cơ, điều dưỡng không tự mở rộng kỹ thuật.

5.2. Thuốc

Không cần thuốc (trong trường hợp thông thường).

Thuốc theo y lệnh/nhãn; không có thuốc bắt buộc nếu kỹ thuật không cần. Kiểm tra cân nặng, liều, nồng độ, ml, đường và tốc độ; không tự thay thuốc hoặc pha trộn.

5.3. Vật tư

- Que lấy mẫu tỵ hầu (swab vô khuẩn, đầu rayon hoặc nylon flocked).

- Ống nghiệm chứa môi trường bảo quản mẫu (VTM, UTM).

- Găng tay sạch, khẩu trang N95, kính chắn giọt bắn, áo choàng chống dịch.

- Túi zip hoặc hộp vận chuyển mẫu.

Vật tư đúng cỡ trẻ và mục đích, vô khuẩn/dùng một lần khi yêu cầu, vệ sinh tay và hộp vật sắc nhọn; không dùng cỡ người lớn mặc định.

5.4. Trang thiết bị

- Khay dụng cụ vô khuẩn, thùng rác y tế.

- Bảng kê người bệnh.

Thiết bị hoạt động tốt, IFU đúng model, bơm/monitor và phương tiện cấp cứu phù hợp trẻ khi cần; kiểm tra trước dùng.

5.5. Người bệnh

Giải thích quy trình, yêu cầu hợp tác (ngửa đầu, không di chuyển).

Hai định danh, giải thích phù hợp tuổi, người chăm sóc; nhận định sinh hiệu, nguy cơ và mức hợp tác, không cố giữ trẻ khi không an toàn.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Phiếu chỉ định xét nghiệm, thông tin hành chính người bệnh.

Chỉ định, cân nặng/tuổi, dị ứng, thuốc đã dùng và kế hoạch theo dõi trong đúng hồ sơ.

5.7. Thời gian thực hiện

5 - 10 phút/kỹ thuật.

Thời gian theo kỹ thuật/tình trạng, ghi thực tế; không để thời gian ước tính trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

phòng lấy mẫu riêng biệt hoặc khu cách ly.

Nơi đủ điều kiện kỹ thuật, hỗ trợ cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn; trẻ cần hồi sức được chuyển nơi phù hợp.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu thông tin, phiếu chỉ định, nhãn bệnh phẩm.

Tạm dừng xác nhận đúng trẻ, chỉ định, vị trí, thuốc/liều/thông số, vật tư và khả năng cấp cứu; xử trí khẩn không chờ hoàn tất hành chính.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Các bước thực hiện

Bước 1: chuẩn bị phương tiện, dụng cụ cần thiết.

Bước 2: rửa tay, mang phương tiện phòng hộ cá nhân đúng quy định.

Bước 3: hướng dẫn, giải thích kỹ thuật cho người bệnh.

Bước 4: yêu cầu người bệnh ngồi thẳng, ngửa nhẹ đầu.

Bước 5: đưa que song song sàn mũi theo giải phẫu, độ sâu phù hợp tuổi và hướng dẫn xét nghiệm; không dùng 7–10 cm cho mọi trẻ. Không ép khi gặp cản trở, chuyển phương án lấy mẫu theo bác sĩ/phòng xét nghiệm.

Bước 6: giữ yên que vài giây, xoay nhẹ rồi rút ra từ từ.

Bước 7: bỏ đầu que vào ống môi trường, bẻ gãy phần thân que (nếu cần), đậy kín nắp.

Bước 8: ghi nhãn đầy đủ thông tin mẫu bệnh phẩm.

Bước 9: bỏ rác y tế vào đúng nơi quy định, tháo phương tiện bảo hộ.

Bước 10: vận chuyển mẫu đến phòng xét nghiệm đúng quy định.

6.2. Ghi hồ sơ

Ghi ngày, giờ lấy mẫu, người thực hiện, dấu hiệu bất thường (nếu có).

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian/thuốc/liều/thông số thực dùng, vị trí, đáp ứng và sự cố; xử lý dụng cụ/chất thải, hướng dẫn người chăm sóc và bàn giao có người nhận.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Hắt hơi, nôn, chảy máu mũi → ngừng thủ thuật, trấn an người bệnh.

7.2. Sau khi thực hiện

Quan sát phản ứng người bệnh (mệt, choáng, khó chịu...).

7.3. Biến chứng muộn

Hiếm gặp, nhưng cần theo dõi nếu có triệu chứng kéo dài (đau họng, chảy máu mũi...).

Diễn biến nguy hiểm: dừng can thiệp liên quan, đánh giá ABCDE, gọi hỗ trợ và xử trí theo tuổi/phác đồ. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, adrenaline tiêm bắp khi có chỉ định phản vệ theo mức độ, không chờ y lệnh mới tiêm. Theo dõi đủ theo tình trạng, báo cáo sự cố và tái đánh giá trước tiếp tục.

Nguồn đối chiếu

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. File nguồn do bệnh viện cung cấp; hướng dẫn Nhi và nhãn/IFU thực tế phải được xác nhận trước ban hành.

Các bảng danh mục trong nguồn không được dùng làm liều hoặc thể tích mặc định. Mục 5 đã tập hợp chuẩn bị; thuốc/cỡ/thông số theo y lệnh và phiếu xác nhận, thay danh mục lặp chưa điều chỉnh theo tuổi.

N-10. QUY TRÌNH ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Định nghĩa: đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên là kỹ thuật sử dụng một ống thông nhỏ đưa vào lòng tĩnh mạch ngoại biên (tay, chân) để truyền dịch, truyền thuốc hoặc lấy máu.

- Nguyên lý: ống catheter được đưa vào lòng tĩnh mạch dưới sự hỗ trợ của kim dẫn đường. Sau khi catheter vào đúng vị trí, kim được rút ra, để lại catheter trong lòng mạch.

- Mục đích:

Catheter ngoại biên là kim luồn ngoại biên; thời gian sử dụng tùy chỉ định và tình trạng, không coi hai tên là hai thiết bị khác nhau.

+ Giảm số lần chọc kim khi điều trị kéo dài.

+ Hạn chế tổn thương tĩnh mạch do truyền thuốc kích ứng.

2. CHỈ ĐỊNH

Khi cần truyền dịch, lấy máu xét nghiệm và thực hiện tiêm, truyền thuốc.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Rối loạn đông máu (chống chỉ định tương đối).

- Huyết khối tĩnh mạch.

- Giãn tĩnh mạch ngoại biên.

Dengue không phải chống chỉ định tuyệt đối của đường truyền cần thiết; bác sĩ cân nhắc nguy cơ chảy máu, chọn vị trí và số lần chọc phù hợp.

4. THẬN TRỌNG

- Người có rối loạn đông máu.

- Người già, trẻ nhỏ, người bệnh có da mỏng.

- Luôn kiểm tra vị trí catheter sau khi đặt và trong quá trình sử dụng.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

- 01 điều dưỡng.

- Trang bị mũ, khẩu trang.

- Vệ sinh bàn tay, đi găng tay vô trùng.

Dung dịch bơm rửa/truyền theo y lệnh và cân nặng; NaCl 0,9% chai 500 ml không có nghĩa truyền 500 ml cho mọi trẻ.

Nhân lực đủ năng lực và phạm vi được phân công; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ khi nguy cơ, điều dưỡng không tự mở rộng kỹ thuật.

5.2. Thuốc

Thuốc theo y lệnh/nhãn; không có thuốc bắt buộc nếu kỹ thuật không cần. Kiểm tra cân nặng, liều, nồng độ, ml, đường và tốc độ; không tự thay thuốc hoặc pha trộn.

5.3. Vật tư

- Gòn, gạc che kim.
- Catheter ngoại biên các cỡ, bộ dây truyền dịch.
- Găng tay sạch.
- Băng keo.
- Chai sát khuẩn tay nhanh.
- Dây garo.

Vật tư đúng cỡ trẻ và mục đích, vô khuẩn/dùng một lần khi yêu cầu, vệ sinh tay và hộp vật sắc nhọn; không dùng cỡ người lớn mặc định.

5.4. Trang thiết bị

- Bộ dụng cụ tiêm truyền vô khuẩn.
- Trụ treo.

Thiết bị hoạt động tốt, IFU đúng model, bơm/monitor và phương tiện cấp cứu phù hợp trẻ khi cần; kiểm tra trước dùng.

5.5. Người bệnh

- Giải thích cho Người bệnh và người nhà kỹ thuật sắp làm.
- Đo mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở.
- Tư thế người thoải mái.
- Vị trí đặt: chọn tĩnh mạch.

Hai định danh, giải thích phù hợp tuổi, người chăm sóc; nhận định sinh hiệu, nguy cơ và mức hợp tác, không cố giữ trẻ khi không an toàn.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, cân nặng/tuổi, dị ứng, thuốc đã dùng và kế hoạch theo dõi trong đúng hồ sơ.

5.7. Thời gian thực hiện

Thời gian theo kỹ thuật/tình trạng, ghi thực tế; không để thời gian ước tính trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Nơi đủ điều kiện kỹ thuật, hỗ trợ cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn; trẻ cần hồi sức được chuyển nơi phù hợp.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra 5 đúng.
- Thực hiện bảng kiểm an toàn kỹ thuật.

Tạm dừng xác nhận đúng trẻ, chỉ định, vị trí, thuốc/liều/thông số, vật tư và khả năng cấp cứu; xử trí khẩn không chờ hoàn tất hành chính.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: kiểm tra chai dịch natrichlorua 0,9%, cắm dây truyền vào chai, xả dịch truyền và khoá lại. Bộc lộ vùng cần đặt catheter, chọn tĩnh mạch.

- Bước 2: đi găng tay sạch, buộc dây garo trên vùng cần đặt 3 - 5 cm.

- Bước 3: sát khuẩn vị trí cần đặt từ trong ra ngoài theo hình xoáy ốc 2 lần, điều dưỡng sát khuẩn tay.

- Bước 4: lắp kim có catheter. Một tay căng da, một tay cầm catheter đâm kim chếch 30 độ so với mặt da vào tĩnh mạch thấy máu trào ra. Rút từ từ nòng kim ra khỏi catheter, lắp dây truyền đã chuẩn bị trước vào đốc catheter.Tháo dây garo, mở khoá cho dịch chảy.

- Bước 5: cố định catheter và dây truyền, che catheter bằng gạc vô khuẩn.

- Bước 6: điều chỉnh tốc độ truyền theo chỉ định.

- Bước 7: giúp người bệnh về tư thế thoải mái, theo dõi và phát hiện tai biến, dặn người bệnh những điều cần thiết.

- Bước 8: thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.

- Bước 9: ghi bệnh án: ghi phiếu chăm sóc, phiếu truyền dịch.

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian/thuốc/liều/thông số thực dùng, vị trí, đáp ứng và sự cố; xử lý dụng cụ/chất thải, hướng dẫn người chăm sóc và bàn giao có người nhận.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

- Theo dõi toàn trạng người bệnh trong quá trình tiến hành kỹ thuật (sắc mặt, mạch, SpO2) để phát hiện tai biến.

- Theo dõi nơi đặt catheter hàng ngày, theo dõi chảy máu, nhiễm khuẩn, thay băng.

Nghi nhiễm khuẩn: báo bác sĩ, xử trí và rút khi có chỉ định; cấy mẫu/đầu catheter theo yêu cầu, không cấy thường quy mọi đầu kim.

Tắc catheter: không cố bơm thông bằng lực; dừng, kiểm tra nguyên nhân và thay/rút theo chỉ định.

Nghi đứt catheter: dừng, báo bác sĩ cấp cứu và xác định phần thiếu, không chỉ đặt lại. Tuột catheter không đưa lại phần đã ra ngoài vào mạch.

Diễn biến nguy hiểm: dừng can thiệp liên quan, đánh giá ABCDE, gọi hỗ trợ và xử trí theo tuổi/phác đồ. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, adrenaline tiêm bắp khi có chỉ định phản vệ theo mức độ, không chờ y lệnh mới tiêm. Theo dõi đủ theo tình trạng, báo cáo sự cố và tái đánh giá trước tiếp tục.

Nguồn đối chiếu

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. File nguồn do bệnh viện cung cấp; hướng dẫn Nhi và nhãn/IFU thực tế phải được xác nhận trước ban hành.

Nguồn tham khảo chuyên môn và an toàn:
https://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/intravenous_access_peripheral/

Các bảng danh mục trong nguồn không được dùng làm liều hoặc thể tích mặc định. Mục 5 đã tập hợp chuẩn bị; thuốc/cỡ/thông số theo y lệnh và phiếu xác nhận, thay danh mục lặp chưa điều chỉnh theo tuổi.

N-11. QUY TRÌNH CHĂM SÓC CATHETER TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Định nghĩa: chăm sóc catheter tĩnh mạch ngoại biên là các thao tác điều dưỡng nhằm duy trì sự thông suốt của đường truyền, phòng ngừa nhiễm khuẩn, phát hiện sớm và xử trí các tai biến, biến chứng liên quan đến catheter.

Duy trì vô khuẩn, theo dõi và thay băng theo tình trạng. Ở trẻ em, thay catheter ngoại biên khi có chỉ định lâm sàng, không thay định kỳ chỉ để phòng nhiễm khuẩn.

- Mục đích:

+ Giữ catheter luôn thông suốt và an toàn.

+ Phòng tránh nhiễm khuẩn và biến chứng.

+ Đảm bảo hiệu quả điều trị và an toàn cho người bệnh.

2. CHỈ ĐỊNH

- Áp dụng cho tất cả người bệnh có đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên.

- Thời gian thực hiện: khi gạc che thấm dịch, máu hoặc thấy viêm đỏ, chảy máu quanh chân catheter.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không thay băng nếu gạc che còn kín, không có hiện tượng viêm nhiễm, chảy máu trước 72 giờ.

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh có nguy cơ cao nhiễm khuẩn: suy giảm miễn dịch, tiểu đường, trẻ sơ sinh, người già.

Đánh giá chỉ định duy trì hằng ngày và mỗi khi có vấn đề; ở trẻ không thay chỉ vì đủ 72–96 giờ.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

điều dưỡng: rửa tay, đội mũ , đeo khẩu trang.

Nhân lực đủ năng lực và phạm vi được phân công; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ khi nguy cơ, điều dưỡng không tự mở rộng kỹ thuật.

5.2. Thuốc

- Nước muối Natriclorua 0,9%.

- PVP iodine 10%.

Thuốc theo y lệnh/nhãn; không có thuốc bắt buộc nếu kỹ thuật không cần. Kiểm tra cân nặng, liều, nồng độ, ml, đường và tốc độ; không tự thay thuốc hoặc pha trộn.

5.3. Vật tư

- Gòn, gạc che kim.

- Dụng cụ chăm sóc hoặc thay băng vô khuẩn.

- Băng keo.

- Túi đựng đồ bẩn.

- Dung dịch rửa tay nhanh.

- Găng tay sạch.

Vật tư đúng cỡ trẻ và mục đích, vô khuẩn/dùng một lần khi yêu cầu, vệ sinh tay và hộp vật sắc nhọn; không dùng cỡ người lớn mặc định.

5.4. Trang thiết bị

không có.

Thiết bị hoạt động tốt, IFU đúng model, bơm/monitor và phương tiện cấp cứu phù hợp trẻ khi cần; kiểm tra trước dùng.

5.5. Người bệnh

- Thông báo, giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh kỹ thuật sắp làm.

- Đặt người bệnh ở tư thế thích hợp.

Hai định danh, giải thích phù hợp tuổi, người chăm sóc; nhận định sinh hiệu, nguy cơ và mức hợp tác, không cố giữ trẻ khi không an toàn.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, cân nặng/tuổi, dị ứng, thuốc đã dùng và kế hoạch theo dõi trong đúng hồ sơ.

5.7. Thời gian thực hiện

Thời gian theo kỹ thuật/tình trạng, ghi thực tế; không để thời gian ước tính trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Nơi đủ điều kiện kỹ thuật, hỗ trợ cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn; trẻ cần hồi sức được chuyển nơi phù hợp.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng xác nhận đúng trẻ, chỉ định, vị trí, thuốc/liều/thông số, vật tư và khả năng cấp cứu; xử trí khẩn không chờ hoàn tất hành chính.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: mở gói dụng cụ, đổ dung dịch nước muối 0,9% vào bát kền.

- Bước 2: đeo găng sạch

- Bước 3: đặt khay quả đậu ở vị trí thích hợp.

- Bước 4: tháo bỏ gạc cũ.

- Bước 5: đánh giá chân catheter, mức độ viêm chân catheter hay không.

Bước 6: bỏ găng bẩn, vệ sinh tay và thao tác vô khuẩn không chạm vùng trọng yếu; sát khuẩn bằng chế phẩm phù hợp tuổi/IFU, chờ khô. Không tự pha loãng PVP iodine 10% theo ước lượng.

- Bước 7: đặt gạc che catheter, băng cố định bằng băng keo.

- Bước 8: tháo bỏ găng bẩn.

- Bước 9: đặt người bệnh về tư thế thoải mái.

- Bước 10: thu dọn dụng cụ.

- Bước 11: rửa tay.

- Bước 12: ghi phiếu chăm sóc: thời gian thực hiện, người thực hiện.

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian/thuốc/liều/thông số thực dùng, vị trí, đáp ứng và sự cố; xử lý dụng cụ/chất thải, hướng dẫn người chăm sóc và bàn giao có người nhận.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

- Theo dõi chân catheter có thấm dịch, máu thì thay ngay. Theo dõi đánh giá chảy máu chỗ, nhiễm trùng tại chân catheter.

- Theo dõi vị trí cố định: mức độ lỏng, tuột của catheter, gập gãy catheter.

- Tuột catheter do cố định lỏng, người bệnh có nhiều mồ hôi người bệnh dãy dụa nhiều.

- Nhiễm trùng chân catheter do lưu catheter quá lâu: thực hiện quy trình thay băng đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn cho người bệnh.

- Tắc catheter: dùng bơm tiêm hút máu ra, tuyệt đối không bơm cục máu đông vào trong.

Diễn biến nguy hiểm: dừng can thiệp liên quan, đánh giá ABCDE, gọi hỗ trợ và xử trí theo tuổi/phác đồ. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, adrenaline tiêm bắp khi có chỉ định phản vệ theo mức độ, không chờ y lệnh mới tiêm. Theo dõi đủ theo tình trạng, báo cáo sự cố và tái đánh giá trước tiếp tục.

Nguồn đối chiếu

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. File nguồn do bệnh viện cung cấp; hướng dẫn Nhi và nhãn/IFU thực tế phải được xác nhận trước ban hành.

Nguồn tham khảo chuyên môn và an toàn:
https://www.cdc.gov/infection-control/media/pdfs/guideline-bsi-h.pdf

Các bảng danh mục trong nguồn không được dùng làm liều hoặc thể tích mặc định. Mục 5 đã tập hợp chuẩn bị; thuốc/cỡ/thông số theo y lệnh và phiếu xác nhận, thay danh mục lặp chưa điều chỉnh theo tuổi.

N-12. QUY TRÌNH CHĂM SÓC CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM

1. ĐẠI CƯƠNG

- Định nghĩa: chăm sóc catheter tĩnh mạch trung tâm là các thao tác điều dưỡng nhằm đảm bảo catheter luôn thông suốt, vô khuẩn và phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết, viêm tĩnh mạch và các biến chứng liên quan đến catheter.

- Nguyên lý: giữ vô khuẩn tuyệt đối trong quá trình chăm sóc và sử dụng catheter; kiểm tra định kỳ để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

- Mục đích:

+ Duy trì chức năng catheter trung tâm ổn định.

+ Phòng tránh nhiễm khuẩn và tắc nghẽn catheter.

+ Tăng hiệu quả điều trị và đảm bảo an toàn người bệnh.

2. CHỈ ĐỊNH

- Áp dụng cho tất cả người bệnh có đặt catheter tĩnh mạch trung tâm.

- Thời gian thực hiện: khi băng thấm dịch, máu, hoặc qua opside thấy viêm đỏ, chảy máu quanh chân catheter.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không thay băng nếu băng opside còn kín, không có hiện tượng viêm nhiễm, chảy máu.

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh có nguy cơ cao nhiễm khuẩn: suy giảm miễn dịch, hóa trị liệu, đang sốt kéo dài.

- Tránh làm bong catheter hoặc làm nhiễm khuẩn trong khi chăm sóc.

- Thực hiện vô khuẩn tuyệt đối.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

điều dưỡng: rửa tay, đội mũ , đeo khẩu trang.

Nhân lực đủ năng lực và phạm vi được phân công; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ khi nguy cơ, điều dưỡng không tự mở rộng kỹ thuật.

5.2. Thuốc

- Natriclorua 0,9%.

- PVP oidine 10%.

Thuốc theo y lệnh/nhãn; không có thuốc bắt buộc nếu kỹ thuật không cần. Kiểm tra cân nặng, liều, nồng độ, ml, đường và tốc độ; không tự thay thuốc hoặc pha trộn.

5.3. Vật tư

- Gòn, gạc.

- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

- Dụng cụ thủ thuật.

- Dụng cụ chăm sóc hoặc thay băng vô khuẩn.

- Opside.

Vật tư đúng cỡ trẻ và mục đích, vô khuẩn/dùng một lần khi yêu cầu, vệ sinh tay và hộp vật sắc nhọn; không dùng cỡ người lớn mặc định.

5.4. Trang thiết bị

Thiết bị hoạt động tốt, IFU đúng model, bơm/monitor và phương tiện cấp cứu phù hợp trẻ khi cần; kiểm tra trước dùng.

5.5. Người bệnh

- Thông báo, giải thích cho người bệnh (nếu người bệnh tỉnh).

- Đặt người bệnh ở tư thế thích hợp: đầu cao 30 độ, nghiêng mặt về bên đối diện đặt catheter.

Hai định danh, giải thích phù hợp tuổi, người chăm sóc; nhận định sinh hiệu, nguy cơ và mức hợp tác, không cố giữ trẻ khi không an toàn.

5.6. Hồ sơ bệnh án

theo quy định Bộ Y tế.

Chỉ định, cân nặng/tuổi, dị ứng, thuốc đã dùng và kế hoạch theo dõi trong đúng hồ sơ.

5.7. Thời gian thực hiện

dự kiến khoản 10 - 15 phút.

Thời gian theo kỹ thuật/tình trạng, ghi thực tế; không để thời gian ước tính trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

phòng bệnh.

Nơi đủ điều kiện kỹ thuật, hỗ trợ cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn; trẻ cần hồi sức được chuyển nơi phù hợp.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra đúng người bệnh, đúng thời gian, đúng chẩn đoán.

Tạm dừng xác nhận đúng trẻ, chỉ định, vị trí, thuốc/liều/thông số, vật tư và khả năng cấp cứu; xử trí khẩn không chờ hoàn tất hành chính.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: mở gói dụng cụ, đổ dung dịch nước muối 0,9% vào chén chun.

- Bước 2: đi găng sạch.

- Bước 3: đặt khay quả đậu ở vị trí thích hợp.

Bước 4: tháo băng cũ nhẹ bằng găng sạch, quan sát vị trí; không vệ sinh qua băng rồi mới tháo.

Bước 5: loại găng bẩn, vệ sinh tay, chuẩn bị trường và dụng cụ vô khuẩn.

- Bước 6: đánh giá chân catheter tĩnh mạch trung tâm, mức độ viêm chân catheter hay không.

Bước 7: mang găng phù hợp vô khuẩn khi chạm vùng hoặc dụng cụ trọng yếu.

Bước 8: sát khuẩn bằng chế phẩm phù hợp tuổi, vị trí và IFU, chờ khô; không áp PVP iodine 10% cho mọi trẻ, nhất là sơ sinh. Khoa KSNK xác nhận tương hợp và nguy cơ da.

- Bước 9: đặt gạc hoặc opside vào chân catheter, băng lại bằng băng keo.

- Bước 10: tháo bỏ găng bẩn.

- Bước 11: đặt người bệnh về tư thế thoải mái.

- Bước 12: thu dọn dụng cụ.

- Bước 13: rửa tay.

- Bước 14: ghi phiếu chăm sóc: ghi diễn biến, thời gian thực hiện, người thực hiện.

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian/thuốc/liều/thông số thực dùng, vị trí, đáp ứng và sự cố; xử lý dụng cụ/chất thải, hướng dẫn người chăm sóc và bàn giao có người nhận.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

- Theo dõi chân catheter có thấm dịch, máu hoặc opside bị bong thì thay ngay.

- Theo dõi đánh giá chảy máu chỗ chọc, nhiễm trùng tại chân catheter.

- Theo dõi vị trí cố định: mức độ lỏng, tuột của catheter, gập gãy catheter.

- Tuột catheter do cố định lỏng, người bệnh có nhiều mồ hôi người bệnh dãy dụa nhiều.

+ Theo dõi thường xuyên vị trí cố định, băng thấm dịch, mồ hôi.

+ Cố định lại catheter đúng vị trí, rút catheter nếu nghi tuột hẳn ra ngoài.

- Nhiễm trùng chân catheter , nhiễm khuẩn huyết: do thay băng không đảm bảo vô khuẩn, để lưu catheter quá lâu: thực hiện quy trình thay băng đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn cho người bệnh.

- Tắc catheter: dùng bơm tiêm hút máu ra, tuyệt đối không bơm cục máu đông vào trong.

- Báo bác sĩ biết khi có viêm chân catheter, phụ bác sĩ rút catheter.

Diễn biến nguy hiểm: dừng can thiệp liên quan, đánh giá ABCDE, gọi hỗ trợ và xử trí theo tuổi/phác đồ. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, adrenaline tiêm bắp khi có chỉ định phản vệ theo mức độ, không chờ y lệnh mới tiêm. Theo dõi đủ theo tình trạng, báo cáo sự cố và tái đánh giá trước tiếp tục.

Nguồn đối chiếu

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. File nguồn do bệnh viện cung cấp; hướng dẫn Nhi và nhãn/IFU thực tế phải được xác nhận trước ban hành.

Nguồn tham khảo chuyên môn và an toàn: https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/intravascular-catheter-related-infection/prevention-strategies.html

Các bảng danh mục trong nguồn không được dùng làm liều hoặc thể tích mặc định. Mục 5 đã tập hợp chuẩn bị; thuốc/cỡ/thông số theo y lệnh và phiếu xác nhận, thay danh mục lặp chưa điều chỉnh theo tuổi.

N-13. QUY TRÌNH ĐẶT ỐNG THÔNG DẠ DÀY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Định nghĩa: đặt ống thông dạ dày là kỹ thuật đưa ống mềm qua mũi hoặc miệng, qua thực quản vào dạ dày để hút dịch tiêu hóa, bơm thuốc hoặc nuôi dưỡng người bệnh.

- Nguyên lý: dựa trên đặc điểm giải phẫu của đường tiêu hóa trên, kỹ thuật phải bảo đảm vô khuẩn, nhẹ nhàng, đúng vị trí nhằm hạn chế tai biến như sặc, thủng, sai vị trí.

- Mục đích:

Hút/giảm áp hoặc lấy dịch theo chỉ định. Rửa dạ dày khi ngộ độc chỉ trong trường hợp được chuyên khoa lựa chọn, không là bước mặc định.

+ Bơm thuốc, nuôi ăn qua đường tiêu hóa khi người bệnh không thể ăn qua miệng.

+ Chuẩn bị cho một số phẫu thuật hoặc thủ thuật.

2. CHỈ ĐỊNH

- Để nuôi dưỡng: đối với những người bệnh hôn mê, co giật, trẻ đẻ non (phản xạ mút, nuốt kém), dị dạng đường tiêu hóa nặng hoặc ăn bằng đường miệng có nguy cơ suy hô hấp hoặc ngạt.

Rửa dạ dày là kỹ thuật riêng có chỉ định/chống chỉ định và bảo vệ đường thở; không mặc định ngộ độc hoặc xuất huyết tiêu hóa đều phải rửa.

- Để dẫn lưu dịch dạ dày, giúp giảm áp lực trong ống tiêu hóa: trong các trường hợp tắc ruột, liệt ruột cơ năng (viêm tụy cấp…) hoặc sau phẫu thuật đường tiêu hóa.

- Theo dõi tình trạng chảy máu dạ dày, sự tái phát của chảy máu dạ dày.

- Lấy dịch dạ dày làm xét nghiệm.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tổn thương ở thực quản: u, dò, bỏng thực quản dạ dày do acid hoặc kiềm mạnh, teo thực quản.

- Nghi thủng dạ dày.

- Áp xe thành họng.

- Tổn thương vùng hàm mặt.

- Bệnh ở thực quản: co thắt, chít hẹp, phình tĩnh mạch, động mạch thực quản.

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh suy giảm ý thức, dễ sặc: cần hút đờm trước, chuẩn bị dụng cụ cấp cứu.

- Trẻ em, người già, người bệnh tâm thần cần theo dõi sát trong và sau khi đặt.

Xác nhận vị trí bằng dịch hút và pH theo ngưỡng được bệnh viện phê duyệt, hoặc X-quang do người đủ năng lực đọc khi cần; không dùng nghe khí hay nhúng ống vào nước.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

điều dưỡng.

Nhân lực đủ năng lực và phạm vi được phân công; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ khi nguy cơ, điều dưỡng không tự mở rộng kỹ thuật.

5.2. Thuốc

Thuốc theo y lệnh/nhãn; không có thuốc bắt buộc nếu kỹ thuật không cần. Kiểm tra cân nặng, liều, nồng độ, ml, đường và tốc độ; không tự thay thuốc hoặc pha trộn.

5.3. Vật tư

Ống dạ dày đúng loại/cỡ theo tuổi, cân nặng, mục đích và IFU; không dùng ống Faucher cỡ người lớn cho mọi trẻ.

- Găng tay sạch: 2 đôi.

Chất bôi trơn tan trong nước phù hợp, không dùng Vaseline/dầu.

- Gạc vô trùng.

- Băng keo.

- Túi dẫn lưu ống thông dạ dày.

- Ống nghe, huyết áp.

- Bơm tiêm 50ml, máy hút (nếu có).

- Ống nghiệm, giá đựng ống nghiệm (nếu có).

- Hộp thuốc chống sốc.

- Chén chun.

Vật tư đúng cỡ trẻ và mục đích, vô khuẩn/dùng một lần khi yêu cầu, vệ sinh tay và hộp vật sắc nhọn; không dùng cỡ người lớn mặc định.

5.4. Trang thiết bị

Thiết bị hoạt động tốt, IFU đúng model, bơm/monitor và phương tiện cấp cứu phù hợp trẻ khi cần; kiểm tra trước dùng.

5.5. Người bệnh

- Động viên, giải thích cho người bệnh thủ thuật sắp làm để người bệnh yên tâm và hợp tác. Nếu người bệnh hôn mê phải giải thích cho người nhà.

- Tháo răng giả (nếu có).

Bác sĩ đánh giá và bảo vệ đường thở khi chỉ định; điều dưỡng chuẩn bị/hỗ trợ, không tự đặt nội khí quản chỉ vì người bệnh hôn mê.

Hai định danh, giải thích phù hợp tuổi, người chăm sóc; nhận định sinh hiệu, nguy cơ và mức hợp tác, không cố giữ trẻ khi không an toàn.

5.6. Hồ sơ bệnh án

theo quy định của Bộ Y tế.

Chỉ định, cân nặng/tuổi, dị ứng, thuốc đã dùng và kế hoạch theo dõi trong đúng hồ sơ.

5.7. Thời gian thực hiện

tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Thời gian theo kỹ thuật/tình trạng, ghi thực tế; không để thời gian ước tính trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

tại phòng bệnh.

Nơi đủ điều kiện kỹ thuật, hỗ trợ cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn; trẻ cần hồi sức được chuyển nơi phù hợp.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

đúng người bệnh, đúng chuẩn đoán, đúng chỉ định.

Tạm dừng xác nhận đúng trẻ, chỉ định, vị trí, thuốc/liều/thông số, vật tư và khả năng cấp cứu; xử trí khẩn không chờ hoàn tất hành chính.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Bước 1: tư thế phù hợp tuổi và tình trạng, có bảo vệ đường thở theo kế hoạch; không mặc định nằm đầu thấp khi hôn mê.

Bước 2: đo chiều dài bằng phương pháp được phê duyệt cho trẻ (ví dụ NEMU theo hướng dẫn phù hợp), đánh dấu; không dùng 45–50 cm hoặc đo tới rốn cho mọi tuổi.

- Bước 3: bôi trơn đầu ống thông (khoảng 5cm, không để dầu đọng trong ống làm người bệnh sặc).

- Bước 4: bảo người bệnh há miệng hoặc dùng dụng cụ mở miệng hoặc canun Guedel (người bệnh không tỉnh), luồn ống thông qua miệng. Nếu khó khăn có thể luồn qua mũi theo đường đi của lỗ mũi.

Bước 5: đưa nhẹ theo đường đã chọn, dừng khi ho/sặc, khó thở, giảm SpO_2 hoặc gặp cản trở; rút khi nghi sai đường, đánh giá an toàn trước đặt lại.

Bước 6: KHÔNG sử dụng ống trước xác nhận. Kiểm tra dịch hút và pH theo quy trình trẻ em đã phê duyệt; RCH dùng pH ≤5. Nếu không lấy được mẫu/pH không đạt hoặc nghi vị trí, báo bác sĩ, xác nhận X-quang khi chỉ định. Không nghe khí hoặc nhúng đầu ống vào cốc nước để xác định.

- Bước 7: cố định ống thông dạ dày bằng băng keo.

- Bước 8: đậy ống thông dạ dày.

- Bước 9: ghi hồ sơ bệnh án: ghi vào phiếu chăm sóc diễn biến của người bệnh, thời gian thực hiện, người thực hiện.

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian/thuốc/liều/thông số thực dùng, vị trí, đáp ứng và sự cố; xử lý dụng cụ/chất thải, hướng dẫn người chăm sóc và bàn giao có người nhận.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

- Toàn trạng: mạch, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ.

- Phản xạ ho sặc tránh hít phải dịch.

- Nôn mửa gây sặc dịch dạ dày: máy hút, đặt nội khí quản.

- Nhịp tim chậm, ngất do kích thích dây X: hồi sức cấp cứu.

- Đặt nhầm vào khí quản: khi thấy người bệnh ho, sặc, tím môi phải rút ống thông ngay.

- Tổn thương vùng mặt.

Diễn biến nguy hiểm: dừng can thiệp liên quan, đánh giá ABCDE, gọi hỗ trợ và xử trí theo tuổi/phác đồ. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, adrenaline tiêm bắp khi có chỉ định phản vệ theo mức độ, không chờ y lệnh mới tiêm. Theo dõi đủ theo tình trạng, báo cáo sự cố và tái đánh giá trước tiếp tục.

Nguồn đối chiếu

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. File nguồn do bệnh viện cung cấp; hướng dẫn Nhi và nhãn/IFU thực tế phải được xác nhận trước ban hành.

Nguồn tham khảo chuyên môn và an toàn: https://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/Nasogastric_and_Orogastric_Tube_Insertion_and_Management/

Các bảng danh mục trong nguồn không được dùng làm liều hoặc thể tích mặc định. Mục 5 đã tập hợp chuẩn bị; thuốc/cỡ/thông số theo y lệnh và phiếu xác nhận, thay danh mục lặp chưa điều chỉnh theo tuổi.

N-14. QUY TRÌNH NUÔI DƯỠNG QUA ỐNG THÔNG DẠ DÀY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Định nghĩa: nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày là kỹ thuật đưa thức ăn, dung dịch nuôi dưỡng hoặc thuốc vào dạ dày thông qua ống thông đã được đặt sẵn, nhằm cung cấp dinh dưỡng cho người bệnh không thể ăn bằng miệng.

- Nguyên lý: dựa trên cơ chế hấp thu của dạ dày - ruột, kỹ thuật cần đảm bảo lượng, tốc độ và thành phần dinh dưỡng phù hợp, đồng thời ngăn ngừa sặc, nhiễm trùng, tắc ống.

- Mục đích:

+ Cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho người bệnh.

+ Hỗ trợ điều trị và phục hồi sức khỏe.

+ Đảm bảo an toàn trong quá trình nuôi ăn không qua đường miệng.

2. CHỈ ĐỊNH

2.1. Người bệnh không thể ăn được

- Người bệnh sau đặt nội khí quản, mở khí quản, Người bệnh đang thở máy.

- Người bệnh mất hoặc giảm khả năng bảo vệ đường thở, rối loạn nuốt, liệt thần kinh hầu họng do mọi nguyên nhân, hôn mê, co giật, tai biến mạch não.

- Người bệnh có bệnh lý đường tiêu hóa: liệt dạ dày, u thực quản chưa gây tắc nghẽn toàn bộ, tổn thương miệng.

2.2. Người bệnh tự ăn ít, cần được cung cấp thêm dinh dưỡng

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Xuất huyết tiêu hóa cấp nặng.

- Các tổn thương loét ăn mòn thực quản dạ dày chưa kiểm soát được.

- Tắc ruột, liệt ruột dạ dày.

Không dung nạp cần bác sĩ đánh giá theo tuổi và tình trạng, không lấy dịch tồn dư một mình làm chống chỉ định tuyệt đối.

- Các chỉ định trước, sau tiểu phẫu phẫu thuật, nội soi....

4. THẬN TRỌNG

- Người bệnh có nguy cơ hít sặc (rối loạn ý thức, liệt cơ hầu họng...).

- Người bệnh có tiền sử trào ngược dạ dày thực quản.

Đánh giá dung nạp: nôn, chướng, đau, phân và toàn trạng. Hút/diễn giải tồn dư theo kế hoạch cá thể, không bắt buộc hút trước mọi bữa cho tất cả trẻ.

- Luôn kiểm tra vị trí ống trước khi bơm dung dịch.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

điều dưỡng đã được đào tạo chuyên khoa Hồi sức cấp cứu.

Nhân lực đủ năng lực và phạm vi được phân công; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ khi nguy cơ, điều dưỡng không tự mở rộng kỹ thuật.

5.2. Thuốc

không có.

Thuốc theo y lệnh/nhãn; không có thuốc bắt buộc nếu kỹ thuật không cần. Kiểm tra cân nặng, liều, nồng độ, ml, đường và tốc độ; không tự thay thuốc hoặc pha trộn.

5.3. Vật tư

- Bơm tiêm 50ml: 01 cái.
- Băng keo.
- Gạc vô trùng.
- Găng sạch : 01 đôi.
- Ống nghe.
- Cốc sạch đựng thức ăn chia độ.
- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh.
- Xà phòng diệt khuẩn.
- Khăn sạch.
- Thức ăn cho người bệnh theo chỉ định (chế độ bệnh lý hoặc sữa).

Vật tư đúng cỡ trẻ và mục đích, vô khuẩn/dùng một lần khi yêu cầu, vệ sinh tay và hộp vật sắc nhọn; không dùng cỡ người lớn mặc định.

5.4. Trang thiết bị

Máy theo dõi nối với cáp điện tim, cáp đo SpO2, cáp đo huyết áp.

Thiết bị hoạt động tốt, IFU đúng model, bơm/monitor và phương tiện cấp cứu phù hợp trẻ khi cần; kiểm tra trước dùng.

5.5. Người bệnh

- Thông báo, giải thích cho người bệnh hoặc gia đình về kỹ thuật sắp làm.

Tư thế đầu cao phù hợp tuổi/tình trạng theo kế hoạch, tránh sặc; trẻ sơ sinh có hướng dẫn tư thế riêng.

Hai định danh, giải thích phù hợp tuổi, người chăm sóc; nhận định sinh hiệu, nguy cơ và mức hợp tác, không cố giữ trẻ khi không an toàn.

5.6. Hồ sơ bệnh án

theo quy định của Bộ Y tế.

Chỉ định, cân nặng/tuổi, dị ứng, thuốc đã dùng và kế hoạch theo dõi trong đúng hồ sơ.

5.7. Thời gian thực hiện

Thời gian theo kỹ thuật/tình trạng, ghi thực tế; không để thời gian ước tính trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

phòng bệnh.

Nơi đủ điều kiện kỹ thuật, hỗ trợ cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn; trẻ cần hồi sức được chuyển nơi phù hợp.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

kiểm tra đúng người bệnh, đúng chỉ định, đúng chẩn đoán.

Tạm dừng xác nhận đúng trẻ, chỉ định, vị trí, thuốc/liều/thông số, vật tư và khả năng cấp cứu; xử trí khẩn không chờ hoàn tất hành chính.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Các bước trước khi cho ăn qua ống thông

- Bước 1: điều dưỡng rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn đúng quy trình kỹ thuật.

- Bước 2: biều dưỡng đội mũ, đeo khẩu trang, đưa dụng cụ đến giường người bệnh.

- Bước 3: đặt Người bệnh ở tư thế đầu cao nghiêng sang một bên, trải khăn trước ngực.

- Bước 4: Chuẩn bị thức ăn theo chỉ định của bác sĩ (sữa, súp bơm qua ống thông.)

6.2. Đánh giá dịch tồn dư dạ dày

Chế độ theo tuổi, cân nặng, bệnh lý và dung nạp; không áp quy trình tồn dư người lớn cho mọi trẻ.

Theo dõi dung nạp và tồn dư nếu được chỉ định; ghi thời điểm và tiêu chí báo bác sĩ riêng cho trẻ.

- Các phương pháp cho ăn qua ống thông dạ dày: 2 phương pháp cơ bản.

Nuôi liên tục: thể tích/tốc độ/ml mỗi giờ theo kế hoạch cá thể và bơm phù hợp.

Nuôi ngắt quãng: lượng/bữa và thời gian theo cân nặng, tuổi và dung nạp.

- Quy trình đối với bữa đầu sau đặt ống thông dạ dày hoặc với các người bệnh cho ăn lại (viêm tụy cấp sau thời gian nhịn ăn):

+ Bước 1: điều dưỡng rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn đúng quy trình kỹ thuật.

+ Bước 2: điều dưỡng đội mũ, đeo khẩu trang, đưa dụng cụ đến giường người bệnh.

+ Bước 3: đặt người bệnh ở tư thế đầu cao nghiêng sang một bên, trải khăn trước ngực.

+ Bước 4: chuẩn bị thức ăn theo chỉ định của bác sĩ (sữa, súp bơm qua ống thông…).

+ Bước 5: kiểm tra vị trí ống thông dạ dày trước khi cho ăn.

Bước 6: tư thế phù hợp kế hoạch theo tuổi, không hiểu “300” là 300 độ.

+ Bước 7: nối ống thông dạ dày với túi đựng thức ăn lỏng, sau đó điều chỉnh giọt.

Bước 8: cho ăn theo tốc độ/ml và loại sữa/thức ăn đã xác nhận; không đẩy nhanh bằng lực bơm tiêm.

Bước 9: bơm rửa bằng nước phù hợp và thể tích cá thể, tính vào tổng dịch; sử dụng kết nối chuyên dụng đường tiêu hóa.

+ Bước 10: ghi hồ sơ bệnh án: ghi phiếu chăm sóc, diễn biến, thời gian thực hiện, người thực hiện.

Lượng/bữa, ml/giờ, loại thức ăn, nước rửa và tiêu chí ngừng/báo bác sĩ phải ghi trên phiếu theo cân nặng. Không áp 120 ml, 40 ml/giờ hay ngưỡng tồn dư 100 ml chung; không tự đổ bỏ dịch rồi chuyển nuôi tĩnh mạch.

- Quy trình đối với người bệnh ăn qua ống thông dạ dày thường quy:

+ Bước 1: điều dưỡng rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn đúng quy trình kỹ thuật.

+ Bước 2: điều dưỡng đội mũ, đeo khẩu trang, đưa dụng cụ đến giường người bệnh.

+ Bước 3: đặt người bệnh ở tư thế đầu cao nghiêng sang một bên, trải khăn trước ngực.

+ Bước 4: chuẩn bị thức ăn theo chỉ định của bác sĩ (sữa, súp bơm qua ống thông…)

+ Bước 5: kiểm tra vị trí ống thông dạ dày trước khi cho ăn.

Bước 6: tư thế theo kế hoạch phù hợp tuổi/tình trạng.

+ Bước 7: nối ống thông dạ dày với túi đựng thức ăn lỏng, sau đó điều chỉnh giọt.

Bước 8: cho ăn theo lượng và tốc độ cá thể, không ép bơm khi tắc/chống lại.

Bước 9: nước và thể tích bơm rửa theo kế hoạch cá thể, tính tổng dịch.

+ Bước 10: ghi hồ sơ bệnh án: ghi diễn biến, thời gian, người thực hiện.

Không dùng 240 ml/3 giờ hoặc 80 ml/giờ cho mọi trẻ; chế độ phải có y lệnh cá thể.

Nôn, chướng, đau, máu hoặc khó thở: ngừng ăn, đánh giá và báo bác sĩ; xử lý tồn dư và lựa chọn đường nuôi theo tình trạng, không dùng ngưỡng 200 ml chung.

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian/thuốc/liều/thông số thực dùng, vị trí, đáp ứng và sự cố; xử lý dụng cụ/chất thải, hướng dẫn người chăm sóc và bàn giao có người nhận.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

- Ống thông vào thanh quản và khí quản gây co thắt thanh môn, khó thở cấp.

- Chảy máu vùng mũi hầu họng do loét tì đè của ống thông dạ dày.

- Nôn trào ngược.

- Trào ngược do thể tích dịch tồn dư quá lớn, đưa vào dạ dày một thể tích quá lớn, do liệt dạ dày ruột chức năng.

- Tụt ống thông dạ dày hoặc bị cuộn trong miệng thực quản khi cho ăn gây trào ngược và sặc vào đường hô hấp.

Diễn biến nguy hiểm: dừng can thiệp liên quan, đánh giá ABCDE, gọi hỗ trợ và xử trí theo tuổi/phác đồ. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, adrenaline tiêm bắp khi có chỉ định phản vệ theo mức độ, không chờ y lệnh mới tiêm. Theo dõi đủ theo tình trạng, báo cáo sự cố và tái đánh giá trước tiếp tục.

Nguồn đối chiếu

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. File nguồn do bệnh viện cung cấp; hướng dẫn Nhi và nhãn/IFU thực tế phải được xác nhận trước ban hành.

Nguồn tham khảo chuyên môn và an toàn: https://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/Nasogastric_and_Orogastric_Tube_Insertion_and_Management/

Các bảng danh mục trong nguồn không được dùng làm liều hoặc thể tích mặc định. Mục 5 đã tập hợp chuẩn bị; thuốc/cỡ/thông số theo y lệnh và phiếu xác nhận, thay danh mục lặp chưa điều chỉnh theo tuổi.

N-15. QUY TRÌNH ĐẶT ỐNG THÔNG DẪN LƯU BÀNG QUANG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Định nghĩa: đặt ống thông dẫn lưu bàng quang là thủ thuật đưa một ống thông tiệt trùng qua niệu đạo vào bàng quang để dẫn lưu nước tiểu ra ngoài.

- Nguyên lý: ống thông được đưa vào niệu đạo đến bàng quang, sau đó cố định để đảm bảo dòng nước tiểu chảy liên tục ra ngoài, giúp theo dõi và điều trị.

- Mục đích:

+ Theo dõi lượng nước tiểu.

+ Điều trị bí tiểu, giữ bàng quang trống.

+ Chuẩn bị cho một số thủ thuật, phẫu thuật.

+ Dự phòng tổn thương do bí tiểu cấp/mạn.

2. CHỈ ĐỊNH

- Trường hợp người bệnh bí tiểu do nhiều nguyên nhân (bệnh lý liệt cơ vòng cổ bàng quang, do dùng thuốc an thần, giãn cơ..).

- Rối loạn tiểu kéo dài: tiểu không tự chủ.

Chỉ định đặt lưu do bác sĩ xác định; không đặt thường quy chỉ để thay chăm sóc da/vệ sinh khi chưa cần.

- Trước và sau các phẫu thuật.

- Lấy nước tiểu làm xét nghiệm giúp chẩn đoán và điều trị.

- Theo dõi số lượng nước tiểu trong các trường hợp sốc, suy thận cấp, người bệnh dùng an thần giãn cơ ….

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Chấn thương niệu đạo như dập, rách, đứt niệu đạo, nhiễm khuẩn niệu đạo mủ.

- U xơ tiền liệt tuyến gây bí tiểu hoàn toàn.

4. THẬN TRỌNG

- Đặt nhẹ nhàng, tránh tổn thương niệu đạo.

- Kiểm tra tình trạng dị ứng latex, thuốc sát khuẩn.

- Cẩn trọng với người bệnh nam lớn tuổi (tăng sinh tuyến tiền liệt).

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

điều dưỡng.

Nhân lực đủ năng lực và phạm vi được phân công; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ khi nguy cơ, điều dưỡng không tự mở rộng kỹ thuật.

5.2. Thuốc

- Natriclorua 0,9%.

- Dung dịch sát khuẩn iode (Povidin) 10%.

- Vaselin.

- Nước cất.

Thuốc theo y lệnh/nhãn; không có thuốc bắt buộc nếu kỹ thuật không cần. Kiểm tra cân nặng, liều, nồng độ, ml, đường và tốc độ; không tự thay thuốc hoặc pha trộn.

5.3. Vật tư

Vật tư đúng cỡ trẻ và mục đích, vô khuẩn/dùng một lần khi yêu cầu, vệ sinh tay và hộp vật sắc nhọn; không dùng cỡ người lớn mặc định.

5.4. Trang thiết bị

- Ống thông bàng quang kích cỡ phù hợp: 01 cái.

- Găng sạch: 01 đôi.

- Găng vô khuẩn.

- Khay quả đậu vô khuẩn.

- Bộ dụng cụ vô khuẩn.

- Khăn có lỗ: 01 cái.

- Gạc củ ấu vô khuẩn, gạc miếng vô khuẩn.

- Bơm tiêm 20ml : 01 cái.

- Ống xét nghiệm (nếu cần).

- Bô dẹt.

- Tấm nilon 40 x 60 cm.

- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Thiết bị hoạt động tốt, IFU đúng model, bơm/monitor và phương tiện cấp cứu phù hợp trẻ khi cần; kiểm tra trước dùng.

5.5. Người bệnh

- Máy theo dõi nối với cáp điện tim, cáp SpO2, cáp đo huyết áp.

- Bình phong.

Hai định danh, giải thích phù hợp tuổi, người chăm sóc; nhận định sinh hiệu, nguy cơ và mức hợp tác, không cố giữ trẻ khi không an toàn.

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Thông báo giải thích cho người bệnh và gia đình về mục đích của việc đặt ống thông bàng quang và yêu cầu sự hợp tác của gia đình người bệnh.

- Che bình phong.

- Người bệnh nằm ngửa, cởi quần, bộc lộ vùng lỗ niệu đạo, đắp ga.

- Trải nilon dưới mông, được vệ sinh bộ phận sinh dục.

Chỉ định, cân nặng/tuổi, dị ứng, thuốc đã dùng và kế hoạch theo dõi trong đúng hồ sơ.

5.7. Thời gian thực hiện

theo quy định của Bộ Y tế.

Thời gian theo kỹ thuật/tình trạng, ghi thực tế; không để thời gian ước tính trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

dự kiến 15 - 20 phút. (5 - 10)

Nơi đủ điều kiện kỹ thuật, hỗ trợ cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn; trẻ cần hồi sức được chuyển nơi phù hợp.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

phòng bệnh.

Tạm dừng xác nhận đúng trẻ, chỉ định, vị trí, thuốc/liều/thông số, vật tư và khả năng cấp cứu; xử trí khẩn không chờ hoàn tất hành chính.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: Kiểm tra dụng cụ, đưa tới giường bệnh

+ Điều dưỡng rửa tay bằng xà phòng tiệt khuẩn đúng quy trình kỹ thuật.

+ Điều dưỡng đội mũ, đeo khẩu trang.

+ Đưa dụng cụ đến giường để ở nơi thuận tiện.

Dùng dung dịch vệ sinh/sát khuẩn phù hợp niêm mạc, tuổi và nhãn/IFU được bệnh viện xác nhận; không mặc định PVP iodine 10% cho mọi trẻ.

+ Tư thế và người bệnh đã được chuẩn bị sẵn, mở ga đắp để lộ bộ phận sinh dục.

- Bước 2: Sát khuẩn vệ sinh vùng sinh dục niệu đạo

+ Điều dưỡng sát khuẩn tay nhanh, đi găng sạch.

Dùng dung dịch vệ sinh/sát khuẩn phù hợp niêm mạc, tuổi và nhãn/IFU được bệnh viện xác nhận; không mặc định PVP iodine 10% cho mọi trẻ.

+ Điều dưỡng tháo bỏ găng sạch, sát khuẩn tay bằng dung dịch rửa tay nhanh.

- Bước 3: Đặt ống thông tiểu vô trùng

+ Đi găng vô khuẩn.

+ Trải khăn có lỗ.

Chuẩn bị dịch bơm bóng đúng loại và thể tích ghi trên catheter được chỉ định; không mặc định 10 ml cho trẻ.

+ Đặt khay quả đậu đã hấp tiệt khuẩn vào giữa 2 đùi người bệnh để đựng nước tiểu.

+ Nối ống thông tiểu với túi dẫn lưu.

Bôi trơn bằng gel tan trong nước phù hợp và vô khuẩn, theo IFU.

+ Tay trái bộc lộ lỗ niệu đạo.

Dùng dung dịch vệ sinh/sát khuẩn phù hợp niêm mạc, tuổi và nhãn/IFU được bệnh viện xác nhận; không mặc định PVP iodine 10% cho mọi trẻ.

+ Tay phải cầm ống thông và nhẹ nhàng đưa ống thông qua niệu đạo vào bàng quang.

Trẻ nam: bộc lộ nhẹ, không cố lộn bao quy đầu; đưa ống nhẹ theo giải phẫu/tuổi và IFU, không dùng độ sâu người lớn. Khi cản trở/đau/chảy máu, dừng báo bác sĩ.

Trẻ nữ: bộc lộ niệu đạo và đưa nhẹ đúng đường theo tuổi; không dùng độ sâu cố định người lớn.

Chỉ bơm bóng nếu dùng catheter có bóng và đã xác nhận ở bàng quang theo kỹ thuật/IFU; thể tích đúng nhãn/y lệnh. Nếu đau/cản trở hoặc không chắc vị trí, không bơm. Một số trẻ nhỏ dùng loại không bóng theo chuyên khoa.

+ Dùng gạc lau khô bộ phận sinh dục và đầu lỗ niệu đạo. Bỏ khăn lỗ.

Duy trì hệ kín, không quấn gạc tẩm sát khuẩn quanh đầu dương vật hoặc chỗ nối thường quy; đưa bao quy đầu về vị trí bình thường nếu đã kéo được.

Cố định tránh căng, túi dưới mức bàng quang, không đặt nền nhà và không gập ống; theo dõi lượng nước tiểu.

+ Đặt người bệnh tư thế thích hợp, đắp ga, mặc lại quần áo cho người bệnh (nếu cần), ghi ngày đặt ống thông. Ghi hồ sơ bệnh án: diễn biến bệnh, thời gian, người thực hiện.

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian/thuốc/liều/thông số thực dùng, vị trí, đáp ứng và sự cố; xử lý dụng cụ/chất thải, hướng dẫn người chăm sóc và bàn giao có người nhận.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

Chảy máu, chấn thương niệu đạo bàng quang: dừng thủ thuật, báo bác sĩ, đánh giá tổn thương, theo dõi các dấu hiệu sinh tồn và cầu bàng quang, tình trạng chảy máu.

7.2. Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

- Nhiễm khuẩn bệnh viện ngược dòng. Tắc ống thông do chảy máu và cục máu đông.

- Chấn thương, rách niệu đạo, tổn thương bàng quang. Đứt rách đầu bàng quang do người bệnh giật rách ống thông.

Diễn biến nguy hiểm: dừng can thiệp liên quan, đánh giá ABCDE, gọi hỗ trợ và xử trí theo tuổi/phác đồ. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, adrenaline tiêm bắp khi có chỉ định phản vệ theo mức độ, không chờ y lệnh mới tiêm. Theo dõi đủ theo tình trạng, báo cáo sự cố và tái đánh giá trước tiếp tục.

Nguồn đối chiếu

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. File nguồn do bệnh viện cung cấp; hướng dẫn Nhi và nhãn/IFU thực tế phải được xác nhận trước ban hành.

Nguồn tham khảo chuyên môn và an toàn:
https://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/indwelling_urinary_catheter_insertion_and_ongoing_care/

Các bảng danh mục trong nguồn không được dùng làm liều hoặc thể tích mặc định. Mục 5 đã tập hợp chuẩn bị; thuốc/cỡ/thông số theo y lệnh và phiếu xác nhận, thay danh mục lặp chưa điều chỉnh theo tuổi.

N-16. QUY TRÌNH ĐẶT ỐNG THÔNG TIỂU 1 LẦN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Định nghĩa: đặt ống thông tiểu một lần là kỹ thuật đưa ống thông tiệt trùng qua niệu đạo vào bàng quang để dẫn lưu nước tiểu ra ngoài rồi rút ra ngay sau khi dẫn lưu xong.

- Nguyên lý: ống thông được đưa vào niệu đạo đến bàng quang để lấy nước tiểu ra ngoài nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị, hoặc làm sạch bàng quang.

- Mục đích:

+ Dẫn lưu nước tiểu tạm thời.

+ Lấy nước tiểu làm xét nghiệm.

+ Làm sạch bàng quang trước các thủ thuật.

+ Kiểm tra tồn lưu nước tiểu sau tiểu tiện.

2. CHỈ ĐỊNH

- Trường hợp người bệnh bí tiểu do nhiều nguyên nhân.

- Lấy nước tiểu làm xét nghiệm giúp chẩn đoán và điều trị.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chấn thương niệu đạo như dập, rách, đứt niệu đạo, nhiễm khuẩn niệu đạo mủ.

4. THẬN TRỌNG

- Thao tác nhẹ nhàng, tránh gây tổn thương niệu đạo.

- Sử dụng ống mềm, kích cỡ phù hợp.

- Cẩn trọng với người bệnh nam lớn tuổi (nguy cơ tổn thương tuyến tiền liệt).

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

điều dưỡng.

Nhân lực đủ năng lực và phạm vi được phân công; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ khi nguy cơ, điều dưỡng không tự mở rộng kỹ thuật.

5.2. Thuốc

- Natriclorua 0,9%.

- Dung dịch sát khuẩn iode (Povidin) 10%.

- Vaselin.

Thuốc theo y lệnh/nhãn; không có thuốc bắt buộc nếu kỹ thuật không cần. Kiểm tra cân nặng, liều, nồng độ, ml, đường và tốc độ; không tự thay thuốc hoặc pha trộn.

5.3. Vật tư

- Ống thông thông tiểu cỡ phù hợp: 01 cái.

- Găng sạch.

- Găng vô khuẩn.

- Khay hạt đậu vô khuẩn.

- Bộ dụng cụ vô khuẩn.

- Khăn có lỗ.

- Gạc củ ấu vô khuẩn, gạc miếng vô khuẩn.

- Bơm tiêm 10ml.

- Ống xét nghiệm (nếu cần).

- Bô dẹt.

- Tấm nilon 40 x 60 cm.

- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Vật tư đúng cỡ trẻ và mục đích, vô khuẩn/dùng một lần khi yêu cầu, vệ sinh tay và hộp vật sắc nhọn; không dùng cỡ người lớn mặc định.

5.4. Trang thiết bị

bình phong.

Thiết bị hoạt động tốt, IFU đúng model, bơm/monitor và phương tiện cấp cứu phù hợp trẻ khi cần; kiểm tra trước dùng.

5.5. Người bệnh

- Thông báo giải thích cho người bệnh và gia đình về mục đích của việc đặt ống thông tiểu và yêu cầu sự hợp tác của gia đình người bệnh.

- Che bình phong.

- Người bệnh nằm ngửa, cởi quần, bộc lộ vùng lỗ niệu đạo, đắp ga.

- Trải nilon dưới mông, được vệ sinh bộ phận sinh dục.

Hai định danh, giải thích phù hợp tuổi, người chăm sóc; nhận định sinh hiệu, nguy cơ và mức hợp tác, không cố giữ trẻ khi không an toàn.

5.6. Hồ sơ bệnh án

theo quy định của Bộ Y tế.

Chỉ định, cân nặng/tuổi, dị ứng, thuốc đã dùng và kế hoạch theo dõi trong đúng hồ sơ.

5.7. Thời gian thực hiện

dự kiến 5 - 10 phút.

Thời gian theo kỹ thuật/tình trạng, ghi thực tế; không để thời gian ước tính trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

phòng bệnh.

Nơi đủ điều kiện kỹ thuật, hỗ trợ cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn; trẻ cần hồi sức được chuyển nơi phù hợp.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng chỉ định.

Tạm dừng xác nhận đúng trẻ, chỉ định, vị trí, thuốc/liều/thông số, vật tư và khả năng cấp cứu; xử trí khẩn không chờ hoàn tất hành chính.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: Kiểm tra dụng cụ, đưa tới giường bệnh

+ Điều dưỡng rửa tay bằng xà phòng tiệt khuẩn đúng quy trình kỹ thuật.

+ Điều dưỡng đội mũ, đeo khẩu trang.

+ Đưa dụng cụ đến giường để ở nơi thuận tiện.

Dùng dung dịch vệ sinh/sát khuẩn phù hợp niêm mạc, tuổi và nhãn/IFU được bệnh viện xác nhận; không mặc định PVP iodine 10% cho mọi trẻ.

+ Tư thế người bệnh đã được chuẩn bị sẵn, mở ga đắp để lộ bộ phận sinh dục.

- Bước 2: Sát khuẩn vệ sinh vùng sinh dục niệu đạo

+ Điều dưỡng sát khuẩn tay nhanh, đeo găng sạch.

Dùng dung dịch vệ sinh/sát khuẩn phù hợp niêm mạc, tuổi và nhãn/IFU được bệnh viện xác nhận; không mặc định PVP iodine 10% cho mọi trẻ.

+ Điều dưỡng tháo bỏ găng sạch, sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

- Bước 3: Đặt ống thông tiểu vô trùng

+ Đi găng vô khuẩn.

+ Trải khăn có lỗ.

Dùng ống thông một lần không bóng phù hợp; không chuẩn bị bơm bóng cho kỹ thuật này.

+ Đặt khay quả đậu đã hấp tiệt khuẩn vào giữa 2 đùi người bệnh để đựng nước tiểu.

Gel bôi trơn tan trong nước vô khuẩn theo IFU; không Vaseline.

+ Tay trái bộc lộ lỗ niệu đạo.

Dùng dung dịch vệ sinh/sát khuẩn phù hợp niêm mạc, tuổi và nhãn/IFU được bệnh viện xác nhận; không mặc định PVP iodine 10% cho mọi trẻ.

+ Tay phải cầm ống thông và nhẹ nhàng đưa ống thông qua niệu đạo vào bàng quang.

Đưa ống một lần ở trẻ nam nhẹ theo giải phẫu/tuổi; không cố lộn bao quy đầu hoặc áp độ sâu người lớn, dừng khi cản trở.

Ở trẻ nữ, đưa nhẹ đúng lỗ niệu đạo theo giải phẫu; dừng khi đau/cản trở, không áp độ sâu cố định.

Khi nước tiểu ra, thu dẫn lưu/lấy mẫu theo chỉ định; KHÔNG bơm bóng chèn với ống thông một lần.

Sau thu đủ/dẫn lưu hoàn tất theo chỉ định, rút ống nhẹ và xử lý dùng một lần; không có bước rút nước bóng.

Mẫu lấy qua catheter thu vô khuẩn theo xét nghiệm; không gọi là mẫu giữa dòng tự tiểu, ghi phương pháp lấy và thời điểm.

+ Dùng gạc lau khô bộ phận sinh dục và đầu lỗ niệu đạo.

+ Bỏ khăn lỗ.

+ Thu dọn dụng cụ.

+ Đặt người bệnh tư thế thích hợp, đắp ga, mặc lại quần áo cho người bệnh.

+ Ghi phiếu chăm sóc.

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian/thuốc/liều/thông số thực dùng, vị trí, đáp ứng và sự cố; xử lý dụng cụ/chất thải, hướng dẫn người chăm sóc và bàn giao có người nhận.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

Chảy máu, chấn thương niệu đạo bàng quang: dừng thủ thuật, báo bác sĩ, đánh giá tổn thương, theo dõi các dấu hiệu sinh tồn và cầu bàng quang, tình trạng chảy máu.

7.2. Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

- Nhiễm khuẩn bệnh viện ngược dòng. Tắc ống thông do chảy máu và cục máu đông.

- Chấn thương, rách niệu đạo, tổn thương bàng quang. Đứt rách đầu bàng quang do Người bệnh giật rách ống thông.

Diễn biến nguy hiểm: dừng can thiệp liên quan, đánh giá ABCDE, gọi hỗ trợ và xử trí theo tuổi/phác đồ. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, adrenaline tiêm bắp khi có chỉ định phản vệ theo mức độ, không chờ y lệnh mới tiêm. Theo dõi đủ theo tình trạng, báo cáo sự cố và tái đánh giá trước tiếp tục.

Nguồn đối chiếu

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. File nguồn do bệnh viện cung cấp; hướng dẫn Nhi và nhãn/IFU thực tế phải được xác nhận trước ban hành.

Nguồn tham khảo chuyên môn và an toàn: https://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/Teaching_and_supporting_Clean_Intermittent_Catheterisation_for_parents_and_children/

Các bảng danh mục trong nguồn không được dùng làm liều hoặc thể tích mặc định. Mục 5 đã tập hợp chuẩn bị; thuốc/cỡ/thông số theo y lệnh và phiếu xác nhận, thay danh mục lặp chưa điều chỉnh theo tuổi.

N-17. QUY TRÌNH KHÍ DUNG THUỐC GIÃN PHẾ QUẢN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Định nghĩa: khí dung thuốc giãn phế quản là kỹ thuật sử dụng máy khí dung để đưa thuốc giãn phế quản dạng hơi vào đường hô hấp, giúp làm giãn cơ trơn đường thở, giảm tắc nghẽn và cải thiện lưu thông khí phế quản.

- Nguyên lý: thuốc giãn phế quản được đưa vào dưới dạng khí dung nhỏ li ti, dễ dàng thẩm thấu vào đường thở và tác động trực tiếp lên cơ trơn của phế quản để làm giãn, cải thiện tình trạng thở khó.

- Mục đích:

+ Giảm tắc nghẽn đường thở, cải thiện lưu thông khí.

+ Điều trị các bệnh lý phổi như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

+ Cải thiện chức năng hô hấp và giảm triệu chứng khó thở.

2. CHỈ ĐỊNH

- Tiền sử hen phế quản, COPD.

- Cơn hen phế quản cấp.

- Co thắt phế quản do nhiễm khuẩn phổi.

- Người bệnh có đờm đặc khô.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh cơ tim tắc nghẽn phì đại hoặc loạn nhịp nhanh.

4. THẬN TRỌNG

- Đảm bảo liều thuốc phù hợp với tình trạng của người bệnh.

- Theo dõi thường xuyên trong suốt quá trình sử dụng thuốc để phát hiện tác dụng phụ.

- Cẩn trọng khi sử dụng ở người bệnh có bệnh tim mạch hoặc tiểu đường.

- Tránh tiếp xúc thuốc với mắt.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

điều dưỡng.

Nhân lực đủ năng lực và phạm vi được phân công; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ khi nguy cơ, điều dưỡng không tự mở rộng kỹ thuật.

5.2. Thuốc

thuốc khí dung theo chỉ định của bác sỹ.

Thuốc theo y lệnh/nhãn; không có thuốc bắt buộc nếu kỹ thuật không cần. Kiểm tra cân nặng, liều, nồng độ, ml, đường và tốc độ; không tự thay thuốc hoặc pha trộn.

5.3. Vật tư

- Bộ dây khí dung dùng riêng cho từng người bệnh.

- Bơm tiêm 5ml, kim rút thuốc.

- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Vật tư đúng cỡ trẻ và mục đích, vô khuẩn/dùng một lần khi yêu cầu, vệ sinh tay và hộp vật sắc nhọn; không dùng cỡ người lớn mặc định.

5.4. Trang thiết bị

Máy khí dung.

Thiết bị hoạt động tốt, IFU đúng model, bơm/monitor và phương tiện cấp cứu phù hợp trẻ khi cần; kiểm tra trước dùng.

5.5. Người bệnh

Thông báo giải thích cho người bệnh hoặc gia đình người bệnh về kỹ thuật sắp làm.

Hai định danh, giải thích phù hợp tuổi, người chăm sóc; nhận định sinh hiệu, nguy cơ và mức hợp tác, không cố giữ trẻ khi không an toàn.

5.6. Hồ sơ bệnh án

theo quy định của Bộ Y tế.

Chỉ định, cân nặng/tuổi, dị ứng, thuốc đã dùng và kế hoạch theo dõi trong đúng hồ sơ.

5.7. Thời gian thực hiện

Thời gian theo kỹ thuật/tình trạng, ghi thực tế; không để thời gian ước tính trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

phòng bệnh.

Nơi đủ điều kiện kỹ thuật, hỗ trợ cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn; trẻ cần hồi sức được chuyển nơi phù hợp.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Thực hiện 5 đúng.

- Thực hiện bảng kiểm an toàn kỹ thuật.

Tạm dừng xác nhận đúng trẻ, chỉ định, vị trí, thuốc/liều/thông số, vật tư và khả năng cấp cứu; xử trí khẩn không chờ hoàn tất hành chính.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: thông báo, động viên người bệnh hợp tác thực hiện kỹ thuật.

- Bước 2: điều dưỡng đội mũ, đeo khẩu trang. Mang dụng cụ, thuốc đến giường bệnh. Đặt người bệnh ở tư thế thích hợp.

- Bước 3: cắm điện và kiểm tra hoạt động của máy khí dung. Cắm bộ dây khí dung vào máy khí dung.

- Bước 4: sát khuẩn tay nhanh. Pha thuốc theo chỉ định. Bơm thuốc vào bình khí dung.

- Bước 5: bật máy khí dung khi máy hoạt động thấy hơi thuốc phun ra.

- Bước 6: đeo mặt nạ khí dung cho người bệnh.

Bước 7: theo dõi hô hấp, SpO_2, mạch và dung nạp. Nếu khó thở tăng/co thắt nghịch thường: dừng, gọi bác sĩ và hỗ trợ hô hấp theo tình trạng, không chỉ báo rồi tiếp tục.

- Bước 8: hết thuốc, tắt máy khí dung, lấy mặt nạ khỏi người bệnh.

- Bước 9: thu dọn dụng cụ, vệ sinh máy khí dung, để đúng nơi quy định.

- Bước 10: rửa tay. Ghi phiếu chăm sóc.

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian/thuốc/liều/thông số thực dùng, vị trí, đáp ứng và sự cố; xử lý dụng cụ/chất thải, hướng dẫn người chăm sóc và bàn giao có người nhận.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

- Mạch, khó thở, SpO2, huyết áp, đờm trong khí phế quản, phát hiện các tai biến và biến chứng.

- Khó thở, suy hô hấp cấp.

- Sặc vào đường hô hấp.

- Trào ngược từ đường tiêu hóa vào đường thở.

Diễn biến nguy hiểm: dừng can thiệp liên quan, đánh giá ABCDE, gọi hỗ trợ và xử trí theo tuổi/phác đồ. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, adrenaline tiêm bắp khi có chỉ định phản vệ theo mức độ, không chờ y lệnh mới tiêm. Theo dõi đủ theo tình trạng, báo cáo sự cố và tái đánh giá trước tiếp tục.

Nguồn đối chiếu

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. File nguồn do bệnh viện cung cấp; hướng dẫn Nhi và nhãn/IFU thực tế phải được xác nhận trước ban hành.

Các bảng danh mục trong nguồn không được dùng làm liều hoặc thể tích mặc định. Mục 5 đã tập hợp chuẩn bị; thuốc/cỡ/thông số theo y lệnh và phiếu xác nhận, thay danh mục lặp chưa điều chỉnh theo tuổi.

N-18. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH

1. ĐẠI CƯƠNG

Trạng thái co giật cần xử trí khi cơn kéo dài ≥5 phút hoặc lặp mà không hồi phục; thời gian không rõ cần đánh giá/xử trí ngay theo cấp cứu.

- Nguyên lý: Ngăn chặn các cơn động kinh kéo dài bằng cách duy trì sự ức chế thần kinh thông qua các thuốc an thần, chống co giật kịp thời và hỗ trợ chức năng sống.

- Mục đích:

+ Ngăn ngừa tổn thương não không hồi phục.

+ Duy trì chức năng hô hấp, tuần hoàn.

+ Ổn định tình trạng thần kinh cho người bệnh.

2. CHỈ ĐỊNH

Cơn ≥5 phút, thời gian không rõ hoặc cơn tái diễn không hồi phục: triển khai cấp cứu theo phác đồ, không chờ quá 5 phút.

- Động kinh kèm suy hô hấp, rối loạn huyết động.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không có chống chỉ định tuyệt đối.

- Thận trọng ở người bệnh dị ứng với thuốc chống co giật.

4. THẬN TRỌNG

- Cẩn thận với liều lượng thuốc an thần ở người bệnh suy gan, suy thận.

- Theo dõi sát chức năng hô hấp khi dùng thuốc an thần mạnh.

- Đề phòng tụt huyết áp sau khi tiêm thuốc.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

a) Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ cấp cứu.

- Điều dưỡng viên.

b) Nhân lực hỗ trợ:

- Kỹ thuật viên xét nghiệm (nếu cần).

- Nhân viên hỗ trợ hồi sức.

Nhân lực đủ năng lực và phạm vi được phân công; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ khi nguy cơ, điều dưỡng không tự mở rộng kỹ thuật.

5.2. Thuốc

- Diazepam (dung dịch tiêm tĩnh mạch).

- Midazolam (tiêm tỉnh mạch hoặc nhỏ mũi).

- Lorazepam (tiêm tĩnh mạch nếu có).

- Thuốc hỗ trợ: Phenytoin, Levetiracetam, Phenobarbital.

Thuốc theo y lệnh/nhãn; không có thuốc bắt buộc nếu kỹ thuật không cần. Kiểm tra cân nặng, liều, nồng độ, ml, đường và tốc độ; không tự thay thuốc hoặc pha trộn.

5.3. Vật tư

- Ống tiêm, kim tiêm vô trùng.

- Dây truyền dịch.

- Bình oxy, mặt nạ oxy.

- Ống nội khí quản, dụng cụ đặt nội khí quản.

Vật tư đúng cỡ trẻ và mục đích, vô khuẩn/dùng một lần khi yêu cầu, vệ sinh tay và hộp vật sắc nhọn; không dùng cỡ người lớn mặc định.

5.4. Trang thiết bị

- Máy hút đờm.

- Monitor theo dõi huyết áp, SpO_2, nhịp tim.

- Máy thở (nếu cần hỗ trợ hô hấp).

Thiết bị hoạt động tốt, IFU đúng model, bơm/monitor và phương tiện cấp cứu phù hợp trẻ khi cần; kiểm tra trước dùng.

5.5. Người bệnh

- Đặt người bệnh nằm tư thế an toàn, nghiêng đầu sang một bên để tránh hít sặc.

- Tháo bỏ các vật dụng nguy hiểm khỏi người bệnh.

Hai định danh, giải thích phù hợp tuổi, người chăm sóc; nhận định sinh hiệu, nguy cơ và mức hợp tác, không cố giữ trẻ khi không an toàn.

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Phiếu chăm sóc điều dưỡng.

- Các chỉ định thuốc từ bác sĩ.

Chỉ định, cân nặng/tuổi, dị ứng, thuốc đã dùng và kế hoạch theo dõi trong đúng hồ sơ.

5.7. Thời gian thực hiện

ước tính: 1 - 2 giờ hoặc cho đến khi kiểm soát được cơn động kinh.

Thời gian theo kỹ thuật/tình trạng, ghi thực tế; không để thời gian ước tính trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

tại phòng bệnh.

Nơi đủ điều kiện kỹ thuật, hỗ trợ cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn; trẻ cần hồi sức được chuyển nơi phù hợp.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra chỉ định của bác sĩ.

- Xác định loại thuốc, liều lượng, đường dùng phù hợp.

Tạm dừng xác nhận đúng trẻ, chỉ định, vị trí, thuốc/liều/thông số, vật tư và khả năng cấp cứu; xử trí khẩn không chờ hoàn tất hành chính.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Bước 1: đánh giá tình trạng người bệnh.

+ Kiểm tra ý thức, hô hấp, tuần hoàn.

+ Xác định có trạng thái động kinh hay không.

- Bước 2: đảm bảo đường thở.

+ Đặt người bệnh nằm nghiêng, hút đờm dãi nếu cần.

+ Đặt ống nội khí quản nếu người bệnh ngừng thở hoặc có nguy cơ tắc nghẽn đường thở.

- Bước 3: thực hiện điều trị ban đầu.

Thuốc benzodiazepine theo phác đồ Nhi/y lệnh: liều mg/kg, trần mg, nồng độ, ml và đường dùng phải xác nhận. KHÔNG áp Diazepam 10 mg hoặc Midazolam 5 mg cố định cho mọi trẻ.

Kiểm tra các liều đã dùng trước viện; tổng liều/lần tối đa theo phác đồ. Tham khảo RCH: không quá hai liều benzodiazepine trước chuyển bước điều trị theo bác sĩ; không lặp vô hạn. Chuẩn bị thuốc hàng hai đúng liều và tốc độ.

- Bước 4: hỗ trợ chức năng sống.

Oxy và hỗ trợ thông khí theo tuổi, thiết bị và tình trạng; bóp bóng khi thở không hiệu quả, không dùng 5–10 lít/phút chung cho mọi mask/trẻ.

+ Đặt đường truyền tĩnh mạch, bù dịch nếu cần.

+ Theo dõi liên tục mạch, huyết áp, SpO_2.

- Bước 5: xử trí nâng cao (nếu cần)

+ Thực hiện các xét nghiệm cấp cứu: điện giải, đường máu, khí máu động mạch.

+ Chuyển người bệnh vào khoa Hồi sức tích cực nếu không kiểm soát được.

- Bước 6: kết thúc quy trình, đánh giá lại tình trạng người bệnh sau khi ngừng cơn động kinh.

- Ghi hồ sơ: ghi đầy đủ thời gian, liều lượng thuốc đã sử dụng, diễn tiến tình trạng sau can thiệp và các can thiệp đã thực hiện.

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian/thuốc/liều/thông số thực dùng, vị trí, đáp ứng và sự cố; xử lý dụng cụ/chất thải, hướng dẫn người chăm sóc và bàn giao có người nhận.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

- Ngưng thở do thuốc an thần.

- Tụt huyết áp.

7.2. Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

Hỗ trợ đường thở/thông khí khi ngừng thở; ép tim khi có chỉ định ngừng tuần hoàn theo hồi sinh Nhi, không mặc định ép tim chỉ vì ngừng thở còn mạch.

- Kiểm soát suy hô hấp muộn.

7.3. Biến chứng muộn

- Tổn thương não do thiếu oxy.

- Viêm phổi hít.

Diễn biến nguy hiểm: dừng can thiệp liên quan, đánh giá ABCDE, gọi hỗ trợ và xử trí theo tuổi/phác đồ. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, adrenaline tiêm bắp khi có chỉ định phản vệ theo mức độ, không chờ y lệnh mới tiêm. Theo dõi đủ theo tình trạng, báo cáo sự cố và tái đánh giá trước tiếp tục.

Nguồn đối chiếu

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. File nguồn do bệnh viện cung cấp; hướng dẫn Nhi và nhãn/IFU thực tế phải được xác nhận trước ban hành.

Nguồn tham khảo chuyên môn và an toàn:
https://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/Seizures_-_acute_management/

Các bảng danh mục trong nguồn không được dùng làm liều hoặc thể tích mặc định. Mục 5 đã tập hợp chuẩn bị; thuốc/cỡ/thông số theo y lệnh và phiếu xác nhận, thay danh mục lặp chưa điều chỉnh theo tuổi.

N-19. QUY TRÌNH GIẢM ĐAU BẰNG MORPHIN TĨNH MẠCH THEO KIỂU PCA

1. ĐẠI CƯƠNG

- Định nghĩa: PCA (Patient Controlled Analgesia) là phương pháp giảm đau qua đường tĩnh mạch cho phép người bệnh tự điều khiển liều thuốc giảm đau (morphin) bằng cách nhấn nút bơm điện tử, giúp kiểm soát đau chủ động.

- Nguyên lý: Thiết bị bơm PCA được cài đặt sẵn các thông số (liều bolus, thời gian khóa, liều tối đa trong 4 giờ…), người bệnh chủ động dùng thuốc giảm đau trong giới hạn an toàn.

- Mục đích:

+ Kiểm soát đau hiệu quả sau phẫu thuật hoặc trong điều trị đau cấp tính, mạn tính.

+ Giảm liều dùng morphin tổng thể.

+ Tăng sự hài lòng và chủ động của người bệnh trong kiểm soát đau.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đau sau mổ.

- Đau do ung thư cần sử dụng opioid.

- Đau cấp nặng không đáp ứng với giảm đau thông thường.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh không hiểu được cách sử dụng bơm PCA.

- Mất tri giác hoặc rối loạn ý thức.

- Suy hô hấp nặng.

- Dị ứng với morphin hoặc opioid.

- Trẻ nhỏ không hợp tác.

4. THẬN TRỌNG

- Người già, người suy thận, suy gan.

- Người bệnh có tiền sử ngưng thở khi ngủ.

- Dùng đồng thời thuốc an thần, ức chế hô hấp.

- Theo dõi sát dấu hiệu suy hô hấp, an thần quá mức.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

- Bác sĩ chuyên khoa chỉ định.

- Điều dưỡng được đào tạo PCA.

Nhân lực đủ năng lực và phạm vi được phân công; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ khi nguy cơ, điều dưỡng không tự mở rộng kỹ thuật.

5.2. Thuốc

Morphin đúng chế phẩm và nồng độ sau pha được bác sĩ/dược sĩ xác nhận; không coi 10 mg/ml là nồng độ bơm PCA cho mọi trẻ.

Thuốc theo y lệnh/nhãn; không có thuốc bắt buộc nếu kỹ thuật không cần. Kiểm tra cân nặng, liều, nồng độ, ml, đường và tốc độ; không tự thay thuốc hoặc pha trộn.

5.3. Vật tư

- Dây truyền tĩnh mạch.

- Bơm PCA.

- Bơm tiêm.

- Găng tay.

- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

- Băng keo.

Vật tư đúng cỡ trẻ và mục đích, vô khuẩn/dùng một lần khi yêu cầu, vệ sinh tay và hộp vật sắc nhọn; không dùng cỡ người lớn mặc định.

5.4. Trang thiết bị

- Máy theo dõi nối với cáp điện tim, cáp SpO_2, cáp huyết áp.

Thiết bị hoạt động tốt, IFU đúng model, bơm/monitor và phương tiện cấp cứu phù hợp trẻ khi cần; kiểm tra trước dùng.

5.5. Người bệnh

- Được giải thích rõ ràng về mục đích, cách sử dụng nút PCA, các dấu hiệu cần báo nhân viên y tế.

Hai định danh, giải thích phù hợp tuổi, người chăm sóc; nhận định sinh hiệu, nguy cơ và mức hợp tác, không cố giữ trẻ khi không an toàn.

5.6. Hồ sơ bệnh án

- Chỉ định bác sĩ.

- Phiếu theo dõi giảm đau PCA.

- Cam kết sử dụng PCA nếu có.

Chỉ định, cân nặng/tuổi, dị ứng, thuốc đã dùng và kế hoạch theo dõi trong đúng hồ sơ.

5.7. Thời gian thực hiện

- Thời gian thiết lập ban đầu: 30 - 60 phút.

- Theo dõi duy trì: liên tục trong suốt thời gian sử dụng PCA.

Thời gian theo kỹ thuật/tình trạng, ghi thực tế; không để thời gian ước tính trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

phòng bệnh, phòng hậu phẫu, khoa hồi sức, nơi có nhân viên y tế theo dõi 24/24 giờ.

Nơi đủ điều kiện kỹ thuật, hỗ trợ cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn; trẻ cần hồi sức được chuyển nơi phù hợp.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra chỉ định bác sĩ, phiếu cam kết, phiếu đánh giá đau ban đầu, thông số cài đặt bơm.

Tạm dừng xác nhận đúng trẻ, chỉ định, vị trí, thuốc/liều/thông số, vật tư và khả năng cấp cứu; xử trí khẩn không chờ hoàn tất hành chính.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Các bước thực hiện

- Bước 1: chuẩn bị đầy đủ thuốc, thiết bị và giải thích kỹ cho người bệnh.

- Bước 2: rửa tay, mang găng tay sạch.

Hai nhân viên đủ thẩm quyền kiểm tra độc lập cân nặng, liều/nồng độ, bolus, khóa, trần, chế độ nền nếu có và giới hạn bơm theo y lệnh; khóa bảo vệ cài đặt.

- Bước 4: nối dây truyền PCA vào đường truyền tĩnh mạch của người bệnh.

Chỉ người bệnh đủ hiểu và khả năng tự nhấn mới dùng PCA. Người nhà KHÔNG nhấn thay; khi trẻ không đủ khả năng, bác sĩ chọn phương án kiểm soát khác có quy trình riêng.

Theo dõi đau, mức an thần, nhịp/công thở, SpO_2 và sinh hiệu theo kế hoạch; oxy có thể che giảm thông khí, không dựa SpO_2 đơn độc. Có phương tiện thông khí và naloxone sẵn theo phác đồ.

- Bước 7: ghi nhận lượng morphin sử dụng, cơn đau và tác dụng phụ.

- Bước 8: kết thúc PCA theo chỉ định bác sĩ, tháo bỏ thiết bị, đánh giá kết quả giảm đau.

6.2. Ghi hồ sơ

- Ghi nhận đầy đủ thời gian bắt đầu và kết thúc sử dụng PCA.

- Liều lượng morphin sử dụng.

- Đánh giá hiệu quả giảm đau và các phản ứng phụ.

- Ghi vào phiếu theo dõi chuyên biệt hoặc bệnh án.

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian/thuốc/liều/thông số thực dùng, vị trí, đáp ứng và sự cố; xử lý dụng cụ/chất thải, hướng dẫn người chăm sóc và bàn giao có người nhận.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Tai biến trong khi thực hiện

- An thần quá mức.

- Ức chế hô hấp.

- Tụt huyết áp.

- Xử trí:

+ Ngưng truyền PCA.

+ Hồi sức tích cực.

+ Dùng Naloxon theo chỉ định bác sĩ.

7.2. Tai biến sau thực hiện

- Buồn nôn, nôn.

- Táo bón.

- Ngứa, bí tiểu.

- Xử trí: dùng thuốc điều trị triệu chứng theo chỉ định.

7.3. Biến chứng muộn

- Lệ thuộc thuốc giảm đau (hiếm gặp).

- Gây ra tình trạng tăng cảm giác đau.

Diễn biến nguy hiểm: dừng can thiệp liên quan, đánh giá ABCDE, gọi hỗ trợ và xử trí theo tuổi/phác đồ. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, adrenaline tiêm bắp khi có chỉ định phản vệ theo mức độ, không chờ y lệnh mới tiêm. Theo dõi đủ theo tình trạng, báo cáo sự cố và tái đánh giá trước tiếp tục.

Nguồn đối chiếu

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. File nguồn do bệnh viện cung cấp; hướng dẫn Nhi và nhãn/IFU thực tế phải được xác nhận trước ban hành.

Nguồn tham khảo chuyên môn và an toàn: https://www.rch.org.au/anaes/pain_management/Patient_Controlled_Analgesia_PCA/

Các bảng danh mục trong nguồn không được dùng làm liều hoặc thể tích mặc định. Mục 5 đã tập hợp chuẩn bị; thuốc/cỡ/thông số theo y lệnh và phiếu xác nhận, thay danh mục lặp chưa điều chỉnh theo tuổi.

Phiếu xác nhận thông số Nhi trước thực hiện

Trẻ/hai định danh; tuổi; cân nặng kg, ngày cân: ……

Mã kỹ thuật, người thực hiện, phạm vi và năng lực: ……

Thuốc/dịch, liều mg/kg hoặc đơn vị/kg, trần, tổng mg/đơn vị: ……

Nồng độ sau pha, ml, dung môi/tương hợp, tốc độ và tổng dịch: ……

Cỡ vật tư, thiết bị/IFU, vị trí và thông số xác nhận: ……

Ống dạ dày: chiều dài, phương pháp/pH hoặc X-quang, người xác nhận và giờ được phép dùng: ……

Nuôi ăn: loại, ml/bữa hoặc ml/giờ, nước rửa, tư thế, dung nạp và tiêu chí ngừng: ……

Co giật: khởi phát, thuốc/liều trước viện, liều hiện tại, lần tối đa và bước tiếp theo: ……

PCA: nồng độ, bolus, khóa, giới hạn, liều nền nếu có, giám sát an thần/hô hấp, người kiểm tra độc lập: ……

Bác sĩ/y lệnh và người kiểm tra; kế hoạch theo dõi và bàn giao: ……

Đối chiếu cần hoàn tất trước ban hành

Khoa Nhi, Dược, KSNK và chuyên khoa liên quan xác nhận phác đồ thuốc theo cân nặng, quy trình hồi sức Nhi, nghiệm pháp dây thắt theo hướng dẫn Dengue hiện hành, chỉ định vỗ rung (không thường quy cho mọi viêm tiểu phế quản), phòng hộ/lấy mẫu và thiết bị. Chưa có đủ phác đồ/IFU nội viện để khẳng định mọi thông số đã được phê duyệt; bản này dùng trình thẩm định.

Đã sửa trực tiếp 116 đoạn và thống nhất 19 quy trình, 7 phần, chuẩn bị 5.1–5.9. File nguồn giữ nguyên.